

神经病学题库_259题_v3

神经病学题库 v3

batch011 | 259题 | 10模块 | 教师重点2026更新版
生成: 2026-06-22 | 工作流: MedGen→MedQC→MedFix→MedReview
题型: A1(121) A2(48) A3(21) B1(24) X(31) 判断(14)

目录

- | M1 绪论 | 8题 |
- | M10 神经-肌肉接头和肌肉疾病 | 15题 |
- | M2 神经解剖与定位诊断 | 51题 |
- | M3 常见症状 | 34题 |
- | M4 病史采集与体格检查 | 16题 |
- | M5 辅助检查 | 16题 |
- | M6 脑血管疾病 | 51题 |
- | M7 运动障碍性疾病 | 18题 |
- | M8 癫痫 | 31题 |
- | M9 周围神经疾病 | 19题 |

M1 绪论 (8题)

batch011-M1-A1-001

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P3

神经系统疾病诊断三步法中的第一步是：

- A. 定位诊断（相关症状） ☒
- B. 定性诊断（相关症状）
- C. 病因诊断（相关症状）
- D. 病理诊断（相关症状）
- E. 必要的辅助检查项目

▼  解析（答案: A）

神经系统疾病的诊断包括定位诊断和定性诊断两个部分，定位诊断是诊断神经系统疾病的第一步。只有明确病变部位后，才能进一步确定病因。

batch011-M1-A1-002

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P1

定向诊断是指判断疾病是否属于：

- A. 内科疾病
- B. 外科疾病
- **C. 神经科疾病** ✓
- D. 精神科疾病
- E. 心血管疾病

▼  解析（答案: C）

定向诊断即判断疾病是否属于神经科疾病。神经系统与全身系统相依相伴，使得其常与其他系统疾病混杂，需要首先确定是否属于神经科范畴。

batch011-M1-A1-003

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P3

定性诊断属于神经系统疾病诊断的哪个部分？

- **A. 病因诊断** ✓
- B. 定向诊断
- C. 定位诊断的第一步
- D. 辅助检查的一部分
- E. 体格检查的延伸

▼  解析（答案: A）

神经系统疾病的诊断包括定位诊断（病变部位诊断）和定性诊断（病因诊断）两个部分。定性诊断即确定病变的性质和病因。

batch011-M1-A1-004

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P2

在神经系统疾病定性诊断中，除病史采集和体格检查外，还应注意：

- **A. 必要的辅助检查项目** ✓
- B. 家属意见（相关症状）
- C. 患者主观感受
- D. 既往用药史（相关症状）
- E. 社会心理因素

▼  解析（答案: A）

神经系统疾病定性诊断中，除了要重视病史采集及体格检查外，还应注意辅助检查的选择和结果解读，以辅助确定病因。

batch011-M1-A1-006

| Bloom: 理解 | 难度: 中等 | 教材P3

以下关于神经系统疾病诊断的叙述，**错误**的是：

- A. 定位诊断在定性诊断之前进行
- B. 定向诊断判断是否属于神经科疾病
- **C. 定性诊断即确定病变部位** ✓
- D. 辅助检查有助于定性诊断
- E. 病史采集是诊断的基础

▼  解析（答案: C）

定性诊断是病因诊断而非病变部位诊断。定位诊断才是确定病变部位。其他选项均正确。

batch011-M1-A1-007

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P1

神经病学的研究对象是：

- **A. 中枢和周围神经系统疾病** ✓
- B. 精神障碍性疾病
- C. 心理行为异常
- D. 脑血管疾病（相关症状）
- E. 肌肉骨骼系统疾病

▼  解析（答案: A）

神经病学是研究中枢神经系统和周围神经系统疾病及骨骼肌疾病的病因、发病机制、临床表现、诊断、治疗和预防的一门临床学科。

batch011-M1-X-001

| Bloom: 分析 | 难度: 基础 | 教材P152

神经系统疾病的诊断过程包括以下哪些步骤？

- **A. 详细询问病史和主诉** ✓
- **B. 神经系统体格检查** ✓
- **C. 必要的辅助检查项目** ✓
- **D. 综合分析病史与检查结果** ✓
- E. 心理评估（相关临床表现）

▼  解析（答案: A、B、C、D）

要求临床医师通过详细的病史采集、细致的体格检查以及相关的辅助检查，运用所学的知识进行全面的综合分析。心理评估非标准诊断步骤的独立组成部分。

batch011-M1-A1-005

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P3

神经系统疾病的诊断中，定位诊断是诊断的第一步。

- A. 正确 ☒
- B. 错误

▼  解析（答案: A）

定位诊断是诊断神经系统疾病的第一步，符合教材P3原文表述。

M10 神经-肌肉接头和肌肉疾病 (15题)

batch011-M10-A1-001

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P356

重症肌无力最常受累的肌群是：

- A. 四肢近端肌（相关症状）
- B. 眼外肌（临床表现） ☒
- C. 延髓肌（临床表现）
- D. 呼吸肌（临床表现）
- E. 颈肌（相关临床表现）

▼  解析（答案: B）

重症肌无力最常受累的肌群是眼外肌，约半数以上患者以眼肌型起病，表现为上睑下垂和复视，具有晨轻暮重和活动后加重的特点。

batch011-M10-A1-002

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P355

重症肌无力的病理基础是：

- A. 突触前膜乙酰胆碱释放减少
- B. 神经肌肉接头突触后膜AChR抗体介导的损害 ☒
- C. 肌肉本身病变（相关表现）
- D. 运动神经元变性
- E. 周围神经脱髓鞘

▼ 解析（答案: B）

重症肌无力是乙酰胆碱受体抗体（AChR-Ab）介导的、补体参与的神经肌肉接头突触后膜损害，导致神经肌肉传递障碍。

batch011-M10-A1-003

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P356

| 重症肌无力症状的波动特征是：

- A. 晨重暮轻、活动后减轻
- **B. 晨轻暮重、活动后加重** ✓
- C. 全天均等、无波动性
- D. 夜间加重、白天正常
- E. 无规律可循

▼ 解析（答案: B）

重症肌无力最具特征性的表现为症状的波动性：晨轻暮重（休息后减轻、活动后加重），即病态疲劳性。

batch011-M10-A1-004

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P359

| 肌无力危象的主要处理措施是：

- A. 立即停用抗胆碱酯酶药物
- **B. 注射新斯的明并保证呼吸支持** ✓
- C. 大剂量激素冲击治疗
- D. 紧急胸腺切除术
- E. 血浆置换（相关临床表现）

▼ 解析（答案: B）

肌无力危象是疾病进展致呼吸肌麻痹性呼吸困难，注射新斯的明后显著好转。处理包括保证呼吸支持和抗胆碱酯酶药物治疗。

batch011-M10-A1-005

| Bloom: 理解 | 难度: 中等 | 教材P359

| 胆碱能危象与肌无力危象的鉴别要点是：

- A. 有无呼吸困难（相关表现）
- **B. 注射新斯的明后症状改善还是加重** ✓
- C. 有无吞咽困难（相关表现）

- D. 肌无力分布不同
- E. 血清抗体滴度不同

▼  解析（答案: B）

注射新斯的明后：肌无力危象症状显著好转，胆碱能危象则肌无力加重并出现毒蕈碱样反应（瞳孔缩小、出汗、流涎等）。

batch011-M10-A1-006

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P358

诊断重症肌无力最有价值的药理学试验是：

- A. 依酚氯铵试验
- **B. 新斯的明试验** 
- C. 阿托品试验
- D. 卡巴胆碱试验
- E. 毛果芸香碱试验

▼  解析（答案: B）

新斯的明试验是诊断重症肌无力的重要药理学试验，肌注新斯的明后30-60分钟内肌无力症状显著改善即为阳性。

batch011-M10-A1-007

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P347

低钾型周期性瘫痪的临床表现**不包括**：

- A. 迅速出现的四肢弛缓性瘫痪
- **B. 明显的肢体感觉障碍** 
- C. 血清钾降低（相关症状）
- D. 呼吸肌和脑神经一般不受累
- E. 补钾治疗有效

▼  解析（答案: B）

低钾性周期性瘫痪特征为迅速出现的四肢弛缓性瘫痪、无感觉障碍、血清钾降低、呼吸肌一般不受累、补钾治疗有效。

batch011-M10-A1-008

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P363

高钾型周期性瘫痪的发病年龄特点为：

- **A. 一般在10岁以前发病** 

- B. 20-30岁发病为主
- C. 40-50岁发病为主
- D. 60岁以上
- E. 各年龄段均匀分布

▼  解析（答案: A）

高钾型周期性瘫痪一般在10岁以前发病，白天运动后发作频率较高，肌无力持续时间短并有肌强直现象。低钾型以20-40岁青壮年男性多见。

batch011-M10-A1-009

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P361

重症肌无力危象的病死率为：

- A. 8.5%
- B. 约8.5%（相关症状）
- **C. 15.4%-50%** 
- D. 20.3%
- E. 25.7%

▼  解析（答案: C）

危象是重症肌无力最危急的状态，病死率为15.4%-50%。因此早期识别、及时处理至关重要。

batch011-M10-A2-001

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P356

患者女，28岁，间断性双眼睑下垂复视3个月。症状晨轻暮重下午加重。查体：双眼上睑下垂，眼球各方向运动有不同程度受限。新斯的明试验阳性。最可能的诊断是：

- A. 眼肌型肌营养不良
- B. 线粒体肌病（相关症状）
- **C. 重症肌无力（眼肌型）** 
- D. Fisher综合征（GBS变异型，三联征）
- E. 动眼神经麻痹（相关表现）

▼  解析（答案: C）

青年女性眼肌受累为主、症状波动（晨轻暮重）、新斯的明试验阳性，符合重症肌无力（眼肌型）的典型临床特征。

batch011-M10-A2-002

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P347

患者男，25岁，晨起发现四肢**不能**活动2小时。既往有类似发作2次。查体：四肢肌力2级，腱反射消失，感觉正常。急查血清钾2.3mmol/L。最可能的诊断是：

- A. 吉兰-巴雷综合征（GBS，脱髓鞘）
- **B. 低钾型周期性瘫痪** ✓
- C. 重症肌无力（AChR抗体介导）
- D. 急性脊髓炎（相关症状）
- E. 癔症性瘫痪（相关症状）

▼  解析（答案: B）

青年男性反复发作性四肢弛缓性瘫痪、感觉正常、血清钾显著降低（2.3mmol/L），符合低钾型周期性瘫痪的典型特征。

batch011-M10-A2-003

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P359

患者男，50岁，重症肌无力病史3年长期服用溴吡斯的明。近2天感冒后出现呼吸困难全身无力加重。最可能的诊断是：

- A. 胆碱能危象
- **B. 肌无力危象** ✓
- C. 反拗危象
- D. 重症肺炎
- E. 肺栓塞

▼  解析（答案: B）

重症肌无力患者在感染（感冒）诱因下出现呼吸困难和全身肌无力加重，最符合肌无力危象。感染是肌无力危象最常见的诱因。

batch011-M10-X-001

| Bloom: 理解 | 难度: 中等 | 教材P356-P358

重症肌无力的临床特征包括：

- **A. 症状波动性（晨轻暮重）** ✓
- **B. 眼外肌最常受累** ✓
- **C. 新斯的明试验阳性** ✓
- **D. 血清AChR抗体可阳性** ✓
- **E. 重复神经电刺激低频递减** ✓

▼  解析（答案: A、B、C、D、E）

重症肌无力特征：症状波动、眼外肌常首先受累、新斯的明试验阳性、血清AChR抗体可阳性、低频重复神经电刺激呈递减反应。

batch011-M10-X-002

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P347

低钾型周期性瘫痪的临床特征包括：

- A. 迅速出现的四肢弛缓性瘫痪 ✓
- B. 无感觉障碍（相关症状） ✓
- C. 血清钾降低（相关症状） ✓
- D. 呼吸肌一般不受累 ✓
- E. 补钾治疗有效 ✓

▼  解析（答案: A、B、C、D、E）

低钾型周期性瘫痪五大特征：迅速出现四肢弛缓性瘫痪、无感觉障碍、血清钾降低、呼吸肌一般不受累、补钾治疗显效。

batch011-M10-TF-001

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P356

重症肌无力症状具有晨重暮轻的波动性特征。

- A. 正确
- B. 错误 ✓

▼  解析（答案: B）

重症肌无力症状为晨轻暮重（而非晨重暮轻），即症状在早晨较轻、下午或活动后加重，休息后减轻。

M2 神经解剖与定位诊断 (51题)

batch011-M2-A1-001

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P3

周围神经系统包括：

- A. 脑神经和脊神经 ✓
- B. 脑和脊髓
- C. 大脑和小脑
- D. 丘脑和下丘脑

- E. 脑干和间脑

▼  解析（答案: A）

中枢神经系统包括脑和脊髓，周围神经系统包括脑神经和脊神经。

batch011-M2-A1-002

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P18

浅感觉**不包括**:

- A. 痛觉（浅感觉的一种）
- B. 温度觉（冷热感知的浅感觉）
- C. 触觉（轻触感知的浅感觉）
- **D. 振动觉（音叉感知的深感觉）** 
- E. 轻触觉（相关临床表现）

▼  解析（答案: D）

浅感觉包括痛觉、温度觉和触觉；深感觉包括运动觉、位置觉和振动觉。

batch011-M2-A1-003

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P20

脊髓前角损害表现为:

- **A. 节段性下运动神经元性瘫痪** 
- B. 上运动神经元性瘫痪
- C. 感觉性共济失调
- D. 分离性感觉障碍（痛温觉丧失而触觉保留）
- E. 锥体束征阳性（相关表现）

▼  解析（答案: A）

前角损害呈节段性下运动神经元性瘫痪，表现为弛缓性瘫痪、肌张力降低、腱反射减弱、肌萎缩。

batch011-M2-A1-004

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P20

脊髓后角损害的特征性感觉障碍是:

- **A. 分离性感觉障碍（痛温觉丧失而触觉保留）** 
- B. 完全性感觉缺失
- C. 感觉过敏（相关临床表现）

- D. 感觉倒错（相关临床表现）
- E. 深感觉障碍为主

▼  解析（答案: A）

后角损害出现分离性感觉障碍，即痛温觉缺失而触觉保留。

batch011-M2-A1-005

| Bloom: 记忆 | 难度: 中等 | 教材P22

| 脊髓半切综合征（Brown-Sequard）的典型表现是：

- **A. 同侧深感觉障碍伴对侧痛温觉障碍** 
- B. 双侧痛温觉消失
- C. 双侧深感觉障碍
- D. 同侧痛温觉障碍伴对侧深感觉障碍
- E. 仅表现为运动障碍

▼  解析（答案: A）

脊髓半切综合征表现为同侧上运动神经元性瘫痪+同侧深感觉障碍+对侧痛温觉障碍。

batch011-M2-A1-006

| Bloom: 理解 | 难度: 中等 | 教材P24

| 脊髓颈膨大横贯性损害的临床表现**不包括**：

- A. 四肢瘫痪（相关临床表现）
- B. 感觉障碍平面在颈部
- C. 上肢为下运动神经元性瘫痪
- **D. 仅下肢受累（相关症状）** 
- E. 可伴括约肌功能障碍

▼  解析（答案: D）

颈膨大横贯性损害时上肢为下运动神经元性瘫痪，下肢为上运动神经元性瘫痪，表现为四肢瘫痪。

batch011-M2-A1-007

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P42

| 下运动神经元性瘫痪的特点**不包括**：

- A. 肌张力降低
- B. 腱反射减弱或消失

- C. 肌萎缩明显
- **D. 病理反射阳性** ✓
- E. 肌束震颤

▼  解析（答案: D）

下运动神经元性瘫痪特点为肌张力降低、腱反射减弱或消失、肌萎缩明显且出现早、可伴肌束震颤，病理反射阴性。

batch011-M2-A1-008

| Bloom: 理解 | 难度: 中等 | 教材P43

| 上运动神经元性瘫痪的肌张力改变为：

- **A. 肌张力增高呈折刀样** ✓
- B. 肌张力降低
- C. 肌张力增高呈铅管样
- D. 肌张力增高呈齿轮样
- E. 肌张力正常

▼  解析（答案: A）

上运动神经元性瘫痪表现为折刀样肌张力增高（痉挛性瘫痪），区别于锥体外系的铅管样和齿轮样肌强直。

batch011-M2-A1-009

| Bloom: 记忆 | 难度: 中等 | 教材P32

| 动眼神经麻痹的临床表现**不包括**：

- **A. 眼球外斜视（相关症状）** ✓
- B. 上睑下垂（相关临床表现）
- C. 瞳孔散大（相关临床表现）
- D. 对光反射消失
- E. 眼球向上向内向下运动受限

▼  解析（答案: A）

动眼神经麻痹表现为上睑下垂，眼球不能向上/向内/向下转动，复视，瞳孔散大，对光反射及调节反射均消失。

batch011-M2-A1-010

| Bloom: 理解 | 难度: 中等 | 教材P34

| 中枢性面瘫与周围性面瘫的主要鉴别点是：

- A. 额纹是否消失 ☒
- B. 口角是否歪斜
- C. 鼻唇沟是否变浅
- D. 能否闭眼
- E. 有无味觉障碍

▼  解析（答案: A）

中枢性面瘫仅面下部表情肌瘫痪，额纹对称能闭眼；周围性面瘫全部表情肌瘫痪，额纹消失不能闭眼。

batch011-M2-A1-011

| Bloom: 理解 | 难度: 中等 | 教材P36

真性延髓麻痹与假性延髓麻痹的共同表现是：

- A. 舌肌萎缩（相关临床表现）
- B. 咽反射消失（相关症状）
- C. 构音障碍和吞咽困难 ☒
- D. 强哭强笑（情感失禁，假性球麻痹特征）
- E. 下颌反射亢进（相关表现）

▼  解析（答案: C）

两者均可出现构音障碍和吞咽困难。真性有舌肌萎缩/咽反射消失；假性有强哭强笑/下颌反射亢进。

batch011-M2-A1-012

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P14

内囊完全损害的典型表现为：

- A. 三偏综合征 ☒
- B. 交叉性瘫痪
- C. 截瘫（双下肢瘫痪）
- D. 单瘫（单个肢体瘫痪）
- E. 四肢瘫（四肢均瘫痪）

▼  解析（答案: A）

内囊完全损害出现三偏综合征：对侧偏瘫+对侧偏身感觉障碍+对侧同向性偏盲。

batch011-M2-A1-013

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P11

脑干损害的典型表现为：

- **A. 交叉性瘫痪** ☒
- B. 三偏综合征
- C. 截瘫（双下肢瘫痪）
- D. 偏瘫伴感觉障碍
- E. 四肢瘫（四肢均瘫痪）

▼  解析（答案: A）

脑干损害的典型表现为交叉性瘫痪：同侧脑神经周围性瘫痪+对侧肢体中枢性瘫痪。

batch011-M2-A1-014

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P16

小脑损害的主要表现**不包括**：

- A. 共济失调（小脑或深感觉通路受损）
- B. 意向性震颤（相关症状）
- C. 肌张力降低（相关症状）
- **D. 偏瘫（一侧肢体瘫痪）** ☒
- E. 眼球震颤（相关临床表现）

▼  解析（答案: D）

小脑损害主要表现为共济失调、意向性震颤、肌张力降低、眼球震颤、构音障碍和步态异常。偏瘫是锥体束受损表现。

batch011-M2-A1-015

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P50

以下属于病理反射的是：

- A. 肱二头肌反射（C5-C6，深反射）
- B. 膝腱反射（L2-L4，深反射）
- **C. Babinski征** ☒
- D. 腹壁反射（相关临床表现）
- E. 跟腱反射（S1-S2，深反射）

▼  解析（答案: C）

Babinski征是锥体束损害时出现的病理反射。其他均为生理反射。

batch011-M2-A1-016

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P48

深反射包括：

- A. 腹壁反射（T7-T12，浅反射）
- B. 提睾反射（L1-L2，浅反射）
- **C. 膝腱反射（L2-L4，深反射）** ✓
- D. 角膜反射（三叉-面神经反射弧）
- E. 咽反射(咽后壁刺激反射)

▼  解析（答案: C）

深反射包括肱二头肌反射、肱三头肌反射、桡骨膜反射、膝腱反射、跟腱反射等。腹壁反射、提睾反射为浅反射。

batch011-M2-A1-017

| Bloom: 理解 | 难度: 中等 | 教材P18

痛温觉传导通路在脊髓内的交叉部位是：

- **A. 脊髓白质前连合** ✓
- B. 延髓锥体交叉
- C. 丘脑腹后外侧核
- D. 内囊后肢
- E. 中央后回

▼  解析（答案: A）

痛温觉传导第二级神经元纤维经脊髓白质前连合交叉至对侧侧索，形成脊髓丘脑侧束上行。

batch011-M2-A1-018

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P3

神经结构病损后出现的症状可分为四组，**不包括**：

- A. 缺损症状
- B. 刺激症状
- C. 释放症状
- D. 断联休克症状
- **E. 变性症状** ✓

▼  解析（答案: E）

神经结构病损后症状分为四组：缺损症状、刺激症状、释放症状和断联休克症状。

batch011-M2-A1-019

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P15

闭锁综合征患者保留的功能是：

- **A. 垂直眼球运动和睁闭眼** ✓
- B. 水平眼球运动和言语功能
- C. 四肢运动功能
- D. 面部表情运动
- E. 吞咽和构音功能

▼  解析（答案: A）

闭锁综合征表现为四肢全瘫、双侧面瘫、不能讲话，但意识清楚，动眼神经与滑车神经功能保留（垂直眼球运动和睁闭眼）。

batch011-M2-A1-020

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P32

颅内压增高时最易受压的脑神经是：

- A. 动眼神经
- B. 三叉神经
- C. 面神经
- **D. 展神经** ✓
- E. 听神经

▼  解析（答案: D）

展神经在脑底行程较长，颅内压增高时易受压，可表现为眼球外展受限和复视。

batch011-M2-A1-021

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P18

深感觉包括以下哪项？

- A. 痛觉（浅感觉的一种）
- B. 温度觉（冷热感知的浅感觉）
- C. 触觉（轻触感知的浅感觉）
- **D. 运动觉（主动运动感知的深感觉）** ✓
- E. 轻触觉（相关临床表现）

▼  解析（答案: D）

深感觉（本体感觉）包括运动觉、位置觉和振动觉。浅感觉包括痛觉、温度觉和触觉。

batch011-M2-A1-TG01

| Bloom: 理解 | 难度: 中等 | 教材P41

下列哪项是假性球麻痹的特征性表现？

- A. 咽反射消失
- B. 舌肌萎缩伴纤颤
- **C. 强哭强笑（情感失禁）** ✓
- D. 发音嘶哑低沉
- E. 吞咽困难进行性加重

▼  解析（答案: C）

假性球麻痹（核上性球麻痹）因双侧皮质延髓束受损引起，特征为咽反射存在（甚至亢进）、强哭强笑（情感失禁）、无舌肌萎缩和纤颤。真性球麻痹（核下性）则表现为咽反射消失、舌肌萎缩伴纤颤、无强哭强笑。两者均可出现构音障碍和吞咽困难。

batch011-M2-A2-001

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P22

患者男，30岁，因背部刀刺伤入院。查体：右下肢肌力2级，肌张力增高，右侧膝腱反射亢进，右侧Babinski征阳性，右侧T10平面以下深感觉障碍，左侧T10平面以下痛温觉消失。最可能的损伤部位是：

- A. 右侧T10后角
- **B. 右侧T10脊髓半切** ✓
- C. 左侧T10脊髓半切
- D. T10脊髓横贯性损害
- E. T10脊髓前角

▼  解析（答案: B）

右侧上运动神经元性瘫痪+右侧深感觉障碍+左侧痛温觉障碍，符合右侧脊髓半切综合征。

batch011-M2-A2-002

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P34

患者男，65岁，突发右侧口角歪斜、右侧鼻唇沟变浅2小时。查体：右侧额纹存在，右侧眼睑闭合有力。该患者最可能的诊断是：

- A. 右侧周围性面瘫
- **B. 左侧中枢性面瘫** ✓
- C. 特发性面神经麻痹
- D. 吉兰-巴雷综合征（GBS，脱髓鞘）
- E. 三叉神经病变（相关表现）

▼  解析（答案: B）

右侧面下部瘫痪但额纹存在能闭眼，提示对侧（左侧）中枢性面瘫。

batch011-M2-A2-003

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P11

患者男，55岁，突发头晕、左侧面部麻木、右侧肢体无力2天。查体：左侧面部痛温觉减退，右侧肢体肌力3级、Babinski征阳性。最可能的病变部位是：

- A. 左侧内囊
- B. 右侧内囊
- **C. 左侧脑桥** ✓
- D. 右侧脑桥
- E. 左侧小脑

▼  解析（答案: C）

左侧面部感觉障碍+右侧肢体瘫痪=交叉性瘫痪，为脑桥损害，病变在左侧。

batch011-M2-A2-004

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P24

患者男，40岁，双下肢麻木无力进行性加重1周。查体：双下肢肌力2级，肌张力增高，双侧Babinski征阳性，T8平面以下所有感觉消失，大小便障碍。最可能的诊断是：

- A. T8脊髓半切综合征
- **B. T8脊髓横贯性损害** ✓
- C. 周围神经病变（相关表现）
- D. 腰椎间盘突出症
- E. 多发性硬化（MS，中枢脱髓鞘）

▼  解析（答案: B）

T8平面以下完全性感觉缺失+上运动神经元性瘫痪+括约肌功能障碍，符合胸髓横贯性损害。

batch011-M2-A2-005

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P78-P79

患儿6岁，因行走不稳3个月就诊。查体：步态蹒跚，指鼻试验阳性，闭目难立征睁眼和闭眼均不稳。最可能的病变部位是：

- A. 脊髓后索
- **B. 小脑蚓部** ✓
- C. 前庭系统
- D. 大脑额叶

- E. 锥体束

▼  解析（答案: B）

躯干和肢体共济失调，闭目难立征睁眼闭眼均不稳（小脑性），提示小脑蚓部病变。

batch011-M2-A2-006

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P14

患者女，68岁，突发左侧肢体无力伴左侧面部麻木2小时。查体：左侧中枢性面瘫，左侧肢体肌力3级，左侧Babinski征阳性，左侧偏身痛觉减退。最可能的病变部位是：

- A. 左侧脑桥
- B. 右侧脑桥
- C. 左侧内囊
- **D. 右侧内囊** 
- E. 左侧大脑皮质

▼  解析（答案: D）

左侧偏瘫+左侧中枢性面瘫+左侧偏身感觉障碍，符合右侧内囊三偏综合征。

batch011-M2-A2-007

| Bloom: 应用 | 难度: 基础 | 教材P34

患者男，35岁，晨起发现左侧口角漏水、左眼**不能**闭合。查体：左侧额纹消失，左侧眼裂变大、Bell征阳性，左侧鼻唇沟变浅。该患者面瘫类型是：

- A. 左侧中枢性面瘫
- B. 右侧中枢性面瘫
- **C. 左侧周围性面瘫** 
- D. 双侧周围性面瘫
- E. 癔症性面瘫

▼  解析（答案: C）

左侧额纹消失、不能闭眼说明全部表情肌均受累，为同侧周围性面瘫的典型表现。

batch011-M2-A2-008

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P20

患者男，20岁，右上肢进行性无力和肌肉萎缩6个月。查体：右手大小鱼际肌萎缩，右上肢肌张力降低，右肱二头肌反射减弱，无感觉障碍。最可能的病变部位是：

- A. 右侧大脑皮质运动区
- B. 颈段皮质脊髓束

- **C. 颈段脊髓前角** ✓

- D. 右侧臂丛神经

- E. 右侧周围神经

▼  解析（答案: C）

节段性下运动神经元性瘫痪（肌萎缩+肌张力降低+腱反射减弱），无感觉障碍，符合脊髓前角损害。

batch011-M2-A2-TG02

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P41

患者男性，65岁，反复脑梗死病史。近半年出现言语含糊不清、饮水呛咳，查体见咽反射存在、下颌反射亢进、强哭强笑，无舌肌萎缩。该患者最可能的诊断是：

- A. 真性球麻痹（核下性）
- **B. 假性球麻痹（核上性）** ✓
- C. 重症肌无力（AChR抗体介导）
- D. 进行性延髓麻痹（ALS型）
- E. 多发性硬化（MS，中枢脱髓鞘）

▼  解析（答案: B）

患者反复脑梗死（双侧皮质延髓束受损基础），咽反射存在+强哭强笑为假性球麻痹（核上性）的特征表现。真性球麻痹应有咽反射消失+舌肌萎缩。进行性延髓麻痹（ALS）有明显舌肌萎缩纤颤。重症肌无力有波动性肌无力。多发性硬化病程复发缓解且有空间多发性。

batch011-M2-A3-001

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P11

患者男，58岁，突发左侧面部麻木、右侧肢体无力伴言语不清1天。既往高血压史。最可能的病变部位是：

- A. 左侧内囊区
- B. 右侧内囊区
- **C. 左侧脑桥区** ✓
- D. 右侧脑桥区
- E. 左侧延髓区

▼  解析（答案: C）

左侧面部麻木（三叉神经核）+右侧肢体上运动神经元瘫痪+言语不清=交叉性瘫痪，定位在左侧脑桥。

batch011-M2-A3-002

| Bloom: 分析 | 难度: 中等 | 教材P181

若该患者同时出现左侧Horner征和左侧共济失调，病变最可能累及：

- A. 脑桥基底部
- B. 脑桥被盖部
- C. 中脑大脑脚
- **D. 延髓背外侧** ✓
- E. 内囊后肢区

▼  解析（答案: D）

Horner征（交感纤维）+共济失调（绳状体）+交叉性感觉障碍=延髓背外侧综合征（Wallenberg）。原定位需修正为延髓而非脑桥。

batch011-M2-A3-003

| Bloom: 分析 | 难度: 中等 | 教材P181

该综合征最常见的责任血管是：

- A. 大脑中动脉
- B. 基底动脉脑桥支
- **C. 椎动脉或小脑后下动脉** ✓
- D. 大脑后动脉
- E. 脉络膜前动脉

▼  解析（答案: C）

延髓背外侧综合征（Wallenberg）由椎动脉或小脑后下动脉（PICA）闭塞引起。

batch011-M2-B1-001

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P41

单瘫的损害部位是：

- **A. 大脑皮质运动区** ✓
- B. 内囊（白质纤维束）
- C. 脑干（中脑脑桥延髓）
- D. 脊髓胸段（相关临床表现）
- E. 脊髓前角（下运动神经元）

▼  解析（答案: A）

单瘫多见于大脑皮质运动区局限性损害。

batch011-M2-B1-002

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P41

偏瘫最常见的损害部位是：

- **A. 内囊（白质纤维束）** ✓
- B. 大脑皮质运动区
- C. 脑干（中脑脑桥延髓）
- D. 脊髓胸段（相关临床表现）
- E. 脊髓前角（下运动神经元）

▼  解析（答案: A）

偏瘫最常见于内囊损害，锥体束在此高度集中。

batch011-M2-B1-003

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P41

截瘫的损害部位是：

- A. 大脑皮质运动区
- B. 内囊（白质纤维束）
- C. 脑干（中脑脑桥延髓）
- **D. 脊髓胸段（相关临床表现）** ✓
- E. 脊髓前角（下运动神经元）

▼  解析（答案: D）

截瘫多见于脊髓胸段横贯性损害，病变以下双侧锥体束受损。

batch011-M2-B1-004

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P32

支配眼球外直肌的脑神经是：

- A. 动眼神经
- B. 滑车神经
- **C. 展神经** ✓
- D. 三叉神经
- E. 面神经

▼  解析（答案: C）

展神经（第VI对脑神经）支配外直肌，使眼球外展。

batch011-M2-B1-005

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P34

支配面部表情肌的脑神经是：

- A. 动眼神经
- B. 滑车神经
- C. 展神经
- D. 三叉神经
- **E. 面神经** ✓

▼  解析（答案: E）

面神经（第VII对脑神经）支配全部面部表情肌。

batch011-M2-B1-006

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P28

支配咀嚼肌的脑神经是：

- A. 动眼神经
- B. 滑车神经
- C. 展神经
- **D. 三叉神经** ✓
- E. 面神经

▼  解析（答案: D）

三叉神经（第V对脑神经）运动纤维支配咀嚼肌。

batch011-M2-B1-007

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P50

Babinski征属于：

- A. 浅反射（皮肤黏膜反射）
- B. 深反射（腱反射/骨膜反射）
- **C. 病理反射（锥体束损害时出现的阳性征）** ✓
- D. 脑膜刺激征（颈强直+克氏征等）
- E. 自主神经反射（相关表现）

▼  解析（答案: C）

Babinski征是锥体束损害的病理反射。

batch011-M2-B1-008

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P49

腹壁反射属于：

- **A. 浅反射（皮肤黏膜反射）** ✓
- B. 深反射（腱反射/骨膜反射）
- C. 病理反射（锥体束损害时出现的阳性征）
- D. 脑膜刺激征（颈强直+克氏征等）
- E. 自主神经反射（相关表现）

▼  解析（答案: A）

腹壁反射属于浅反射（皮肤反射），反射通路经过脊髓相应节段和皮质脊髓束。

batch011-M2-B1-009

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P48

膝腱反射属于：

- **A. 深反射（腱反射/骨膜反射）** ✓
- B. 浅反射（皮肤黏膜反射）
- C. 病理反射（锥体束损害时出现的阳性征）
- D. 脑膜刺激征（颈强直+克氏征等）
- E. 自主神经反射（相关表现）

▼  解析（答案: A）

膝腱反射属于深反射（腱反射），反射中枢在L2-L4节段。

batch011-M2-X-001

| Bloom: 理解 | 难度: 中等 | 教材P43

上运动神经元性瘫痪的特点包括：

- **A. 肌张力增高呈折刀样** ✓
- **B. 腱反射亢进（上运动神经元损害的体征）** ✓
- **C. 病理反射阳性（相关表现）** ✓
- D. 肌萎缩早期出现且明显
- E. 肌束震颤常见（相关表现）

▼  解析（答案: A、B、C）

上运动神经元性瘫痪特点：折刀样肌张力增高、腱反射亢进、病理反射阳性、晚期废用性肌萎缩、无肌束震颤。

batch011-M2-X-002

| Bloom: 理解 | 难度: 中等 | 教材P34

周围性面瘫的临床特点包括：

- A. 病变侧额纹消失 ✓
- B. 病变侧眼睑闭合不全 ✓
- C. 病变对侧口角歪斜
- D. 同侧全部表情肌瘫痪 ✓
- E. 可伴舌前2/3味觉障碍 ✓

▼  解析（答案: A、B、D、E）

周围性面瘫：同侧全部表情肌瘫痪、额纹消失、不能闭眼、口角歪向健侧、可伴味觉障碍。

batch011-M2-X-003

| Bloom: 分析 | 难度: 中等 | 教材P22

脊髓半切综合征（Brown-Sequard）的表现包括：

- A. 同侧上运动神经元性瘫痪 ✓
- B. 同侧深感觉障碍 ✓
- C. 对侧痛温觉障碍 ✓
- D. 双侧触觉保留 ✓
- E. 括约肌功能障碍常见

▼  解析（答案: A、B、C、D）

脊髓半切综合征：同侧上运动神经元性瘫痪+同侧深感觉障碍+对侧痛温觉障碍。触觉可部分保留。

batch011-M2-X-004

| Bloom: 分析 | 难度: 中等 | 教材P11

脑干损害的临床特点包括：

- A. 交叉性瘫痪（相关症状） ✓
- B. 交叉性感觉障碍（一侧面部+对侧肢体感觉异常） ✓
- C. 可伴多组脑神经受损 ✓
- D. 意识障碍常见（相关表现） ✓
- E. 三偏综合征（相关症状）

▼ 解析（答案: A、B、C、D）

脑干损害特点：交叉性瘫痪、交叉性感觉障碍、多组脑神经受损、意识障碍。三偏综合征是内囊损害特征。

batch011-M2-X-005

| Bloom: 理解 | 难度: 中等 | 教材P16

| 小脑损害的主要临床表现包括：

- A. 共济失调（小脑或深感觉通路损害） 
- B. 意向性震颤（相关症状） 
- C. 肌张力增高呈折刀样（锥体束损害）
- D. 眼球震颤（相关临床表现） 
- E. 爆破性语言（相关症状） 

▼ 解析（答案: A、B、D、E）

小脑损害：共济失调、意向性震颤、肌张力降低、眼球震颤、爆破性语言。肌张力增高非小脑损害特征。

batch011-M2-X-006

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P20

| 脊髓后角损害的临床特点包括：

- A. 节段性痛温觉缺失 
- B. 触觉保留（相关临床表现） 
- C. 深感觉正常（相关症状） 
- D. 分离性感觉障碍（痛温觉丧失而触觉保留） 
- E. 上运动神经元性瘫痪

▼ 解析（答案: A、B、C、D）

脊髓后角损害：分离性感觉障碍（痛温觉缺失+触觉保留）、深感觉正常、不伴运动障碍。

batch011-M2-TF-001

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P42-P43

| 下运动神经元性瘫痪表现为肌张力增高、腱反射亢进、病理反射阳性。

- A. 正确
- B. 错误 

▼ 解析（答案: B）

下运动神经元性瘫痪应为肌张力降低、腱反射减弱或消失、病理反射阴性。题干描述的是上运动神经元性瘫痪。

batch011-M2-TF-002

| Bloom: 分析 | 难度: 基础 | 教材P22

脊髓半切综合征患者表现为同侧深感觉障碍和对侧痛温觉障碍。

- A. 正确 ☒
- B. 错误

▼  解析（答案: A）

脊髓半切综合征特征为同侧上运动神经元性瘫痪+同侧深感觉障碍+对侧痛温觉障碍。

M3 常见症状 (34题)

batch011-M3-A1-001

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P60

以意识内容改变为主意识障碍是：

- A. 嗜睡（可唤醒状态）
- B. 昏睡（强刺激可唤醒）
- C. 昏迷（意识完全丧失）
- D. 谵妄（意识模糊伴精神运动兴奋） ☒
- E. 去皮质状态（相关症状）

▼  解析（答案: D）

谵妄是以意识内容改变为主意识障碍，表现为意识模糊伴大量幻觉、错觉和精神运动性兴奋。嗜睡、昏睡、昏迷均以觉醒度改变为主。

batch011-M3-A1-002

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P61

脑死亡判定中持续观察时间至少为：

- A. 发病后4小时内
- B. 发病后6小时内
- C. 12小时 ☒
- D. 症状持续24小时以上
- E. 48小时

▼ 解析（答案: C）

脑死亡判定需持续至少12小时，经各种抢救无效，并须除外急性药物中毒、低温和内分泌代谢疾病等可逆因素。

batch011-M3-A1-003

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P64

| 运动性失语的病变部位在：

- **A. 额下回后部（相关症状）** 
- B. 颞上回后部（相关症状）
- C. 角回（顶叶后部）
- D. 颞中回（相关临床表现）
- E. 顶叶缘上回（相关症状）

▼ 解析（答案: A）

运动性失语（Broca失语）表现为能理解语言但不能表达，病变位于优势半球额下回后部（Broca区）。

batch011-M3-A1-004

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P64

| 感觉性失语的病变部位在：

- **A. 颞上回后部** 
- B. 额下回后部
- C. 角回（顶叶后部）
- D. 中央前回
- E. 枕叶视觉皮质区

▼ 解析（答案: A）

感觉性失语（Wernicke失语）表现为听不懂他人语言，自身言语流利但错乱，病变位于优势半球颞上回后部。

batch011-M3-A1-005

| Bloom: 理解 | 难度: 中等 | 教材P65

| 说不出物品名称但能描述其用途属于：

- A. 运动性失语（Broca失语，表达障碍）
- B. 感觉性失语（Wernicke失语，理解障碍）
- **C. 命名性失语（找词困难，颞叶后部）** 

- D. 传导性失语（复述障碍为主，弓状束）
- E. 完全性失语（表达和理解均严重障碍）

▼  解析（答案: C）

命名性失语（遗忘性失语）表现为不能说出物品名称，但能描述其用途和性质，病变多位于颞中回后部或角回。

batch011-M3-A1-006

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P70

| 眩晕的定义是：

- **A. 对空间定位障碍产生的运动性或位置性错觉** 
- B. 头部昏沉不适感
- C. 站立不稳的平衡障碍
- D. 眼前发黑伴晕厥前兆
- E. 头晕伴恶心呕吐的综合征

▼  解析（答案: A）

眩晕是指机体因对空间定位产生障碍而发生的一种运动性或位置性错觉。

batch011-M3-A1-007

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P72

| 以下属于感觉倒错的是：

- A. 对刺激敏感性增高
- B. 对刺激敏感性降低
- **C. 冷刺激产生热感** 
- D. 轻微刺激产生强烈感觉
- E. 无刺激时产生异常感觉

▼  解析（答案: C）

感觉倒错是指对刺激性质的错误感知，如冷刺激产生热感。A为感觉过敏，B为感觉减退，D为感觉过度，E为感觉异常。

batch011-M3-A1-008

| Bloom: 理解 | 难度: 中等 | 教材P78

| 感觉性共济失调的特征性表现是：

- A. 睁眼时共济失调加重
- B. 伴爆破性语言

- C. 伴意向性震颤
- D. 伴眼球震颤（相关症状）
- **E. 闭眼时共济失调明显加重** ✓

▼  解析（答案: E）

感觉性共济失调的特征是闭目难立征阳性：睁眼时视觉可代偿部分平衡，闭眼时共济失调明显加重。

batch011-M3-A1-009

| Bloom: 理解 | 难度: 中等 | 教材P79

| 前庭性共济失调的主要特征为：

- A. 肢体共济失调伴意向性震颤
- B. 闭眼时共济失调明显加重
- **C. 平衡障碍为主伴眩晕和眼球震颤** ✓
- D. 上肢共济失调重于下肢
- E. 伴肌张力增高和腱反射亢进

▼  解析（答案: C）

前庭性共济失调以平衡障碍为主（躯干性），常伴眩晕、恶心呕吐和眼球震颤。小脑性以肢体共济失调为主。

batch011-M3-A1-010

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P78-P79

| 痉挛性偏瘫步态的损伤部位是：

- A. 双侧锥体束
- B. 前庭系统
- C. 小脑蚓部
- D. 脊髓后索
- **E. 单侧皮质脊髓束** ✓

▼  解析（答案: E）

痉挛性偏瘫步态为单侧皮质脊髓束受损所致，患侧下肢伸直、足内翻、行走时由外向内划圈。

batch011-M3-A1-011

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P80

| 跨阈步态最常见于：

- A. 帕金森病（黑质多巴胺神经元变性）

- B. 痉挛性截瘫（相关症状）
- C. 小脑蚓部病变（相关表现）
- D. 脊髓后索病变（相关表现）
- **E. 腓总神经麻痹（相关表现）** ✓

▼  解析（答案: E）

跨阈步态（公鸡步态）表现为患足下垂，行走时膝关节抬高以避免足尖拖地，最常见于腓总神经麻痹。

batch011-M3-A1-012

| Bloom: 理解 | 难度: 中等 | 教材P60

| 嗜睡与昏睡的主要区别在于：

- A. 有无自主运动
- B. 有无瞳孔对光反射
- C. 有无睡眠-觉醒周期
- D. 有无病理反射
- **E. 唤醒后能否正确回答问题** ✓

▼  解析（答案: E）

嗜睡患者可被唤醒且能正确回答问题；昏睡患者需较强刺激才能唤醒，醒后不能正确回答问题。

batch011-M3-A1-013

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P71

| 以下最常见引起中枢性眩晕的是：

- A. 梅尼埃病（内淋巴积水致发作性眩晕）
- B. 良性位置性眩晕
- **C. 椎-基底动脉供血不足** ✓
- D. 前庭神经炎（病毒感染致急性眩晕）
- E. 迷路炎（相关临床表现）

▼  解析（答案: C）

椎-基底动脉供血不足属中枢性眩晕（脑干、小脑病变），其余选项均为周围性眩晕的常见病因。

batch011-M3-A1-014

| Bloom: 理解 | 难度: 中等 | 教材P69

癫痫发作与晕厥鉴别中支持癫痫发作的是：

- A. 发作间期脑电图正常
- B. 心血管系统异常常见
- **C. 发作间期脑电图异常** ✓
- D. 发作后无神经系统定位体征
- E. 发作常由体位改变诱发

▼  解析（答案: C）

癫痫发作间期脑电图常异常（痫样放电），晕厥则发作间期脑电图多正常且心血管系统异常常见。

batch011-M3-A1-015

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P72

无外界刺激而产生的主观感觉异常称为：

- A. 感觉过敏
- B. 感觉减退
- C. 感觉倒错
- **D. 感觉异常** ✓
- E. 感觉过度

▼  解析（答案: D）

感觉异常是指没有外界刺激的情况下产生的异常感觉，如麻木感、蚁走感、针刺感、烧灼感等。

batch011-M3-A1-016

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P80

慌张步态最常见于：

- A. 小脑蚓部病变（相关表现）
- B. 进行性肌营养不良
- C. 脊髓后索病变（相关表现）
- D. 腓总神经麻痹（相关表现）
- **E. 帕金森病（黑质多巴胺神经元变性）** ✓

▼  解析（答案: E）

慌张步态（前冲步态）是帕金森病的特征性步态：起步困难、躯干前倾、步幅小且越走越快。

batch011-M3-A2-001

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P64

患者男，60岁，突发言语**不能**2小时。能理解他人言语、可用手势表达，但无法说出完整词语。该失语类型是：

- A. 感觉性失语（Wernicke失语，理解障碍）
- **B. 运动性失语（Broca失语，表达障碍）** ✓
- C. 命名性失语（找词困难，颞叶后部）
- D. 传导性失语（复述障碍为主，弓状束）
- E. 经皮质混合性失语

▼  解析（答案: B）

能理解语言但不能表达（口语表达障碍），理解力保留，符合运动性失语（Broca失语）的典型表现。

batch011-M3-A2-002

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P60

患者男，70岁，因肺部感染入院后出现精神错乱、躁动不安、夜间加重、大量视幻觉。最可能的意识障碍类型是：

- A. 嗜睡（可唤醒状态）
- B. 昏睡（强刺激可唤醒）
- C. 浅昏迷（强刺激可唤醒）
- **D. 谵妄（意识模糊伴精神运动兴奋）** ✓
- E. 去大脑强直（中脑红核水平以下损害）

▼  解析（答案: D）

急性意识模糊、定向力障碍、大量视幻觉、精神运动性兴奋、夜间加重，符合谵妄的典型临床特征。

batch011-M3-A2-003

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P71

患者女，45岁，反复发作性眩晕伴恶心呕吐、耳鸣、左耳胀满感、听力下降，每次持续数十分钟至数小时。最可能的诊断是：

- A. 良性位置性眩晕
- **B. 梅尼埃病（内淋巴积水致发作性眩晕）** ✓
- C. 椎-基底动脉TIA
- D. 前庭神经炎（病毒感染致急性眩晕）
- E. 听神经瘤（相关临床表现）

▼ 解析（答案: B）

反复发作性眩晕伴耳鸣、耳内胀满感、听力下降（耳蜗症状），发作间期正常，符合梅尼埃病的临床表现。

batch011-M3-A2-004

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P78

患者男，55岁，双下肢麻木走路不稳半年。查体：双下肢深感觉减退，闭目难立征阳性（睁眼可站稳闭眼后明显晃动）。该共济失调类型是：

- A. 小脑性共济失调
- **B. 感觉性共济失调** 
- C. 前庭性共济失调
- D. 额叶性共济失调
- E. 混合性共济失调

▼ 解析（答案: B）

闭目难立征阳性（睁眼可站稳、闭眼晃动）是感觉性共济失调的典型特征，深感觉减退提示本体感觉传入障碍。

batch011-M3-A2-005

| Bloom: 应用 | 难度: 基础 | 教材P80

患者男，65岁，帕金森病史5年。行走时起步困难，起步后躯干前倾、步伐越走越快呈前冲状难以停止。该步态是：

- A. 共济失调步态
- B. 剪刀步态
- **C. 慌张步态** 
- D. 跨阈步态
- E. 摇摆步态

▼ 解析（答案: C）

慌张步态（前冲步态）是帕金森病的特征性表现：起步困难、躯干前倾、步幅小、越走越快。

batch011-M3-A2-006

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P64

患者女，55岁，脑梗死后言语障碍3个月。言语流利但内容空洞、含大量错语，**不能理解他人言语**，复述障碍。该失语类型是：

- A. 运动性失语（Broca失语，表达障碍）

- **B. 感觉性失语（Wernicke失语，理解障碍）** 
- C. 命名性失语（找词困难，颞叶后部）
- D. 传导性失语（复述障碍为主，弓状束）
- E. 经皮质运动性失语

▼  解析（答案: B）

言语流利但听理解障碍、复述障碍、言语空洞，符合感觉性失语（Wernicke失语）的典型表现。

batch011-M3-A3-001

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P71

患者女，50岁，反复发作性眩晕伴恶心呕吐3个月，每次持续数十分钟至数小时，发作时伴右耳耳鸣和听力下降。发作间期无任何不适。最可能的诊断是：

- A. 良性位置性眩晕
- **B. 梅尼埃病（内淋巴积水致发作性眩晕）** 
- C. 椎-基底动脉TIA
- D. 前庭神经炎（病毒感染致急性眩晕）
- E. 听神经瘤（相关临床表现）

▼  解析（答案: B）

反复发作性眩晕+耳鸣+听力下降（耳蜗症状）+发作间期正常，符合梅尼埃病的典型表现。

batch011-M3-A3-002

| Bloom: 理解 | 难度: 中等 | 教材P71

该患者眩晕最可能的病变部位是：

- A. 脑干前庭神经核
- B. 小脑绒球小结叶
- **C. 内耳膜迷路** 
- D. 前庭神经颅内段
- E. 大脑颞叶皮质区

▼  解析（答案: C）

梅尼埃病的病理基础为内耳膜迷路积水，病变部位在内耳（周围性），因此属于周围性眩晕。

batch011-M3-A3-003

| Bloom: 分析 | 难度: 中等 | 教材P71-P173

若将梅尼埃病与椎-基底动脉TIA的眩晕进行鉴别，以下支持TIA的是：

- A. 眩晕持续数小时伴耳鸣耳聋
- **B. 眩晕数分钟伴脑干或小脑体征** ✓
- C. 发作间期听力图异常
- D. 发作性眩晕多见于青年女性
- E. 前庭功能检查半规管功能减退

▼  解析（答案: B）

椎-基底动脉TIA属中枢性眩晕，发作时间短（数分钟），常伴脑干或小脑体征。梅尼埃病持续数小时伴耳蜗症状。

batch011-M3-B1-001

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P64

病变位于额下回后部Broca区，以口语表达障碍为主的失语是：

- **A. 运动性失语（Broca失语，表达障碍）** ✓
- B. 感觉性失语（Wernicke失语，理解障碍）
- C. 命名性失语（找词困难，颞叶后部）
- D. 传导性失语（复述障碍为主，弓状束）
- E. 完全性失语（表达和理解均严重障碍）

▼  解析（答案: A）

运动性失语（Broca失语）以口语表达障碍为主、理解力保留，病变在优势半球额下回后部。

batch011-M3-B1-002

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P64

病变位于颞上回后部Wernicke区，以听理解障碍为主的失语是：

- A. 运动性失语（Broca失语，表达障碍）
- B. 完全性失语（表达和理解均严重障碍）
- C. 命名性失语（找词困难，颞叶后部）
- D. 传导性失语（复述障碍为主，弓状束）
- **E. 感觉性失语（Wernicke失语，理解障碍）** ✓

▼  解析（答案: E）

感觉性失语（Wernicke失语）以听理解障碍为主、言语流利但空洞，病变在优势半球颞上回后部。

batch011-M3-B1-003

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P65

复述障碍突出而理解力和表达力相对保留的失语是：

- A. 运动性失语（Broca失语，表达障碍）
- B. 感觉性失语（Wernicke失语，理解障碍）
- C. 命名性失语（找词困难，颞叶后部）
- **D. 传导性失语（复述障碍为主，弓状束）** ✓
- E. 完全性失语（表达和理解均严重障碍）

▼  解析（答案: D）

传导性失语以复述障碍为突出特点，理解力和自发表达相对保留，病变位于弓状纤维束。

batch011-M3-X-001

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P60

以觉醒度改变为主的意识障碍包括：

- **A. 嗜睡（可唤醒状态）** ✓
- **B. 昏睡（强刺激可唤醒）** ✓
- **C. 昏迷（意识完全丧失）** ✓
- D. 谵妄（意识模糊伴精神运动兴奋）
- E. 意识模糊（定向力障碍伴精神运动紊乱）

▼  解析（答案: A、B、C）

以觉醒度改变为主的意识障碍包括嗜睡、昏睡、昏迷。谵妄和意识模糊以意识内容改变为主。

batch011-M3-X-002

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P78

共济失调的分类包括：

- **A. 小脑性共济失调** ✓
- **B. 感觉性共济失调** ✓
- **C. 前庭性共济失调** ✓
- **D. 额叶性共济失调** ✓
- E. 运动性共济失调

▼  解析（答案: A、B、C、D）

共济失调根据病变部位分为小脑性、感觉性（后索性）、前庭性和额叶性四类。运动性共济失调不是独立分类。

batch011-M3-X-003

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P64-P65

以下属于失语类型的有：

- A. 运动性失语（Broca失语，表达障碍） ✓
- B. 感觉性失语（Wernicke失语，理解障碍） ✓
- C. 命名性失语（找词困难，颞叶后部） ✓
- D. 传导性失语（复述障碍为主，弓状束） ✓
- E. 构音障碍（相关临床表现）

▼  解析（答案: A、B、C、D）

失语包括运动性、感觉性、命名性、传导性、经皮质性和完全性失语等。构音障碍是发音器官运动障碍，非失语。

batch011-M3-X-004

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P78-P80

以下属于常见异常步态的有：

- A. 痉挛性偏瘫步态 ✓
- B. 共济失调步态 ✓
- C. 慌张步态 ✓
- D. 跨阈步态 ✓
- E. 剪刀步态 ✓

▼  解析（答案: A、B、C、D、E）

常见异常步态包括痉挛性偏瘫步态、剪刀步态、共济失调步态、慌张步态、跨阈步态、摇摆步态等。

batch011-M3-TF-001

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P60

谵妄是觉醒度和意识内容均有改变的严重意识障碍。

- A. 正确 ✓
- B. 错误

▼  解析（答案: A）

谵妄是以意识内容改变为主意识障碍，但严重时觉醒度也会下降。

batch011-M3-TF-002

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P71

椎-基底动脉供血不足引起的眩晕属于周围性眩晕。

- A. 正确
- **B. 错误** 

▼  解析（答案: B）

椎-基底动脉供血不足引起的眩晕属中枢性眩晕，病位在脑干或小脑。周围性眩晕源于内耳至前庭神经颅外段病变。

M4 病史采集与体格检查 (16题)

batch011-M4-A1-001

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P92

| 神经系统疾病病史采集中最重要的是：

- A. 既往史（过去疾病史）
- B. 个人史（生活饮食习惯）
- **C. 现病史（本次发病全过程）** 
- D. 家族史（遗传相关疾病）
- E. 婚育史（婚姻生育情况）

▼  解析（答案: C）

现病史是病史采集的核心，需详细询问起病方式、症状演变过程、伴随症状等。

batch011-M4-A1-002

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P92

| 面对患者对既往诊治过程的抱怨，正确的处理方式是：

- A. 赞同患者的批评意见
- B. 对其他医生妄加评论
- **C. 进行劝解且不评论其他医生** 
- D. 建议患者更换医院就诊
- E. 回避谈论既往诊治经过

▼  解析（答案: C）

应进行劝解且不要对其他医生妄加评论，这是病史采集的职业素养原则。

batch011-M4-A1-003

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P102

一侧软腭麻痹时腭垂偏向：

- A. 患侧（病变同侧）
- B. 向后方(向咽后壁)
- C. 正中（悬雍垂居中）
- D. 向前方(向口腔方向)
- **E. 健侧（病变对侧）** ✓

▼  解析（答案: E）

一侧麻痹时患侧腭弓低垂，软腭上提差，腭垂偏向健侧。健侧软腭上提正常将腭垂拉向健侧。

batch011-M4-A1-004

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P107

感觉系统检查时正确的起始方向是：

- A. 从正常部位查向感觉缺失部位
- B. 从躯干查向四肢末端
- C. 从肢体近端查向远端
- D. 仅检查症状明显的一侧
- **E. 从感觉缺失部位查向正常部位** ✓

▼  解析（答案: E）

检查时自感觉缺失部位查向正常部位，自肢体远端查向近端，注意左右对比和远近端对比。

batch011-M4-A1-005

| Bloom: 记忆 | 难度: 中等 | 教材P97

用于判断脑干功能损害的反射**不包括**：

- A. 睫脊反射
- B. 角膜反射
- C. 头眼反射
- D. 前庭眼动反射
- **E. 腹壁反射** ✓

▼  解析（答案: E）

脑干反射包括睫脊反射、角膜反射、反射性眼球运动（头眼反射和前庭眼动反射）。腹壁反射为脊髓节段反射。

batch011-M4-A1-006

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P111

脑膜刺激征检查**不包括**：

- A. 颈强直(颈部抵抗感)
- B. Kernig征
- C. Brudzinski征
- **D. Babinski征** ✓
- E. 屈颈试验（相关临床表现）

▼  解析（答案: D）

脑膜刺激征包括颈强直、Kernig征和Brudzinski征。Babinski征是病理反射用于判断锥体束损害。

batch011-M4-A1-007

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P108

浅反射检查**不包括**：

- A. 腹壁反射（T7-T12，浅反射）
- B. 提睾反射（L1-L2，浅反射）
- C. 跖反射(足底刺激反射)
- D. 肛门反射（S3-S5，浅反射）
- **E. 膝腱反射（L2-L4，深反射）** ✓

▼  解析（答案: E）

浅反射包括腹壁反射、提睾反射、跖反射、肛门反射等。膝腱反射属于深反射（腱反射）。

batch011-M4-A1-008

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P112

自主神经功能检查**不包括**以下哪项？

- A. 皮肤黏膜外观和营养状态
- B. 毛发指甲的外观和营养状态
- C. 出汗情况（相关临床表现）
- **D. 肌力和肌张力** ✓
- E. 瞳孔反射（相关临床表现）

▼  解析（答案: D）

自主神经功能检查注意皮肤黏膜和毛发指甲的外观和营养状态、出汗情况及瞳孔反射。肌力和肌张力属运动系统检查。

batch011-M4-A2-001

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P102

患者男，50岁，吞咽困难饮水呛咳。查体：发长音时腭垂偏向左侧，右侧软腭低垂上提差，右侧咽反射消失。该体征提示：

- A. 左侧舌咽迷走神经损害
- **B. 右侧舌咽迷走神经损害** ✓
- C. 双侧皮质脑干束损害
- D. 左侧三叉神经运动核损害
- E. 右侧面神经损害

▼  解析（答案: B）

腭垂偏向健侧（左侧），右侧软腭低垂上提差，右侧咽反射消失，提示右侧舌咽迷走神经周围性损害。

batch011-M4-A2-002

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P107

为确定双下肢麻木患者的感觉障碍平面，查体时应首先：

- **A. 从足部向躯干方向检查痛觉** ✓
- B. 从躯干向足部方向检查痛觉
- C. 仅检查双侧足底的触觉
- D. 先检查上肢再检查下肢
- E. 仅检查位置觉和振动觉

▼  解析（答案: A）

感觉检查应自感觉缺失部位查向正常部位，自肢体远端查向近端。双下肢麻木应从足部向躯干方向检查。

batch011-M4-A2-003

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P111

患者男，30岁，突发剧烈头痛伴恶心呕吐2小时。查体：颈强直阳性，Kernig征双侧阳性。最可能的诊断是：

- **A. 蛛网膜下腔出血（SAH，动脉瘤破裂常见）** ✓
- B. 偏头痛发作（相关症状）
- C. 紧张性头痛（相关症状）
- D. 丛集性头痛（单侧眼眶周围剧烈发作性头痛）
- E. 脑梗死（缺血性脑卒中）

▼  解析（答案: A）

突发剧烈头痛伴脑膜刺激征阳性，高度提示蛛网膜下腔出血。脑膜刺激征是血液刺激脑膜所致。

batch011-M4-B1-001

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P111

Kernig征属于：

- A. 深反射（腱反射/骨膜反射）
- B. 浅反射（皮肤黏膜反射）
- C. 病理反射（锥体束损害时出现的阳性征）
- **D. 脑膜刺激征（颈强直+克氏征等）** ✓
- E. 自主神经反射（相关表现）

▼  解析（答案: D）

Kernig征是脑膜刺激征之一，患者仰卧屈髋屈膝90度后伸膝出现疼痛且伸展受限为阳性。

batch011-M4-B1-002

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P110

Hoffmann征属于：

- A. 深反射（腱反射/骨膜反射）
- B. 浅反射（皮肤黏膜反射）
- **C. 病理反射（锥体束损害时出现的阳性征）** ✓
- D. 脑膜刺激征（颈强直+克氏征等）
- E. 自主神经反射（相关表现）

▼  解析（答案: C）

Hoffmann征是上肢的病理反射，检查者快速弹压患者中指指甲，引起拇指屈曲内收为阳性，提示锥体束损害。

batch011-M4-X-001

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P111

脑膜刺激征包括以下哪些体征？

- **A. 颈强直(颈部抵抗感)** ✓
- **B. Kernig征** ✓
- **C. Brudzinski征** ✓
- D. Babinski征
- E. Oppenheim征

▼ 解析（答案: A、B、C）

脑膜刺激征包括颈强直、Kernig征和Brudzinski征。Babinski征和Oppenheim征为病理反射，用于评估锥体束损害。

batch011-M4-X-002

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P98-P103

| 运动系统检查内容包括：

- A. 肌力检查 
- B. 肌张力检查 
- C. 共济运动检查 
- D. 不自主运动检查 
- E. 姿势和步态检查 

▼ 解析（答案: A、B、C、D、E）

运动系统检查包括肌力、肌张力、共济运动、不自主运动、姿势和步态五个方面的全面评估。

batch011-M4-TF-001

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P107

| 感觉系统检查时应自感觉缺失部位查向正常部位，自肢体远端查向近端。

- A. 正确 
- B. 错误

▼ 解析（答案: A）

教材明确：检查时自感觉缺失部位查向正常部位，自肢体远端查向近端，注意左右对比。

M5 辅助检查 (16题)

batch011-M5-A1-001

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P114

| 腰椎穿刺术后患者应去枕平卧的时间为：

- A. 1-2小时
- B. 2-3小时
- C. 4-6小时 
- D. 6-8小时

- E. 8-12小时

▼ 解析（答案: C）

腰穿术后至少去枕平卧4-6小时以减少低颅压头痛的发生。一旦出现低颅压症状宜多饮水和卧床休息。

batch011-M5-A1-002

| Bloom: 理解 | 难度: 中等 | 教材P114

腰椎穿刺的禁忌证**不包括**:

- A. 严重高颅压（相关症状）
- B. 明显视神经乳头水肿
- C. 临床诊断颅后窝占位性病变
- D. 穿刺部位皮肤感染
- E. 怀疑蛛网膜下腔出血 

▼ 解析（答案: E）

腰穿相对禁忌证包括严重的高颅压、明显视神经乳头水肿、临床诊断颅后窝占位性病变者。怀疑SAH是适应证。

batch011-M5-A1-003

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P115

脑脊液由哪个结构产生？

- A. 脉络丛（脑室内的血管丛） 
- B. 蛛网膜颗粒（相关症状）
- C. 硬脑膜窦（相关临床表现）
- D. 脑实质（神经元和胶质细胞）
- E. 室管膜（脑室壁上皮层）

▼ 解析（答案: A）

脑脊液主要由侧脑室和第三、四脑室的脉络丛产生，经蛛网膜颗粒回吸收入静脉窦。

batch011-M5-A1-004

| Bloom: 记忆 | 难度: 中等 | 教材P116

导致脑脊液中细胞数增高的常见疾病**不包括**:

- A. 中枢神经系统感染
- B. 蛛网膜下腔出血（SAH，动脉瘤破裂常见）
- C. 脑膜癌病（相关临床表现）

- D. 吉兰-巴雷综合征（GBS，脱髓鞘） 
- E. 化脓性脑膜炎（相关表现）

▼  解析（答案: D）

吉兰-巴雷综合征典型脑脊液改变为蛋白-细胞分离现象（蛋白增高而细胞数正常），而非细胞数增高。

batch011-M5-A1-005

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P116

吉兰-巴雷综合征的典型脑脊液改变是：

- A. 细胞数和蛋白均增高
- B. 细胞数增高而蛋白正常
- C. 蛋白增高而细胞数正常 
- D. 细胞数和蛋白均正常
- E. 糖和氯化物降低

▼  解析（答案: C）

吉兰-巴雷综合征的典型脑脊液改变为蛋白-细胞分离现象，即蛋白质含量明显增高而白细胞计数正常或轻度增高。

batch011-M5-A1-006

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P125

DWI对以下哪种疾病最具诊断价值？

- A. 脑肿瘤（颅内占位性病变）
- B. 脑萎缩（脑组织体积缩小）
- C. 脑出血（高血压性颅内出血）
- D. 多发性硬化（MS，中枢脱髓鞘）
- E. 急性脑梗死（相关症状） 

▼  解析（答案: E）

DWI对急性脑梗死具有极高敏感性和特异性，可在发病数分钟内显示细胞毒性水肿所致的水分子扩散受限。

batch011-M5-A1-007

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P118-P122

神经系统疾病常用的电生理检查不包括：

- A. 脑电图（EEG，大脑电活动记录）

- B. 肌电图（EMG，肌肉电活动记录）
- C. 诱发电位（EP，感觉或运动通路评估）
- D. 经颅多普勒超声
- **E. PET-CT（相关表现）** 

▼  解析（答案: E）

神经系统常用电生理检查包括脑电图（EEG）、肌电图（EMG）和诱发电位（EP）等。PET-CT属于核医学影像检查。

batch011-M5-A1-008

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P114

腰椎穿刺通常选取的穿刺间隙是：

- A. L1-L2（相关症状）
- B. L2-L3（相关症状）
- **C. L3-L4或L4-L5** 
- D. L5-S1（相关症状）
- E. T12-L1

▼  解析（答案: C）

腰椎穿刺通常选取L3-L4或L4-L5椎间隙，因成人脊髓末端通常在L1-L2水平，可避免损伤脊髓。

batch011-M5-A2-001

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P114

患者女，35岁，头痛呕吐3天。查体：颈强直阳性。为明确诊断拟行腰穿，以下哪项是禁忌证？

- A. 患者近期有感冒病史
- **B. 眼底检查显示明显视神经乳头水肿** 
- C. 既往有腰椎间盘突出病史
- D. 患者正处于月经期
- E. 患者年龄小于40岁

▼  解析（答案: B）

眼底检查显示明显视神经乳头水肿提示严重高颅压，为腰穿的相对禁忌证，此时腰穿可能诱发脑疝。

batch011-M5-A2-002

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P125

患者男，65岁，突发右侧肢体无力1小时。CT平扫未见异常。下一步最有价值的检查是：

- A. 头颅MRI平扫
- **B. 头颅MRI弥散加权成像** ✓
- C. 脑血管造影（相关症状）
- D. 经颅多普勒超声
- E. 脑电图检查（相关症状）

▼  解析（答案: B）

急性脑梗死超早期CT常无异常，DWI可在发病数分钟内显示细胞毒性水肿，对超早期脑梗死有极高诊断价值。

batch011-M5-A2-003

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P116

患者男，40岁，进行性四肢无力1周。脑脊液：白细胞 $5 \times 10^6/L$ ，蛋白1.5g/L，糖和氯化物正常。该结果最符合：

- A. 化脓性脑膜炎（相关表现）
- B. 结核性脑膜炎（相关表现）
- **C. 吉兰-巴雷综合征（GBS，脱髓鞘）** ✓
- D. 病毒性脑膜炎（相关表现）
- E. 蛛网膜下腔出血（SAH，动脉瘤破裂常见）

▼  解析（答案: C）

脑脊液蛋白显著增高（1.5g/L）而白细胞正常，呈现典型的蛋白-细胞分离现象，符合吉兰-巴雷综合征。

batch011-M5-B1-001

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P116

化脓性脑膜炎的脑脊液典型改变是：

- **A. 细胞数增高以中性粒细胞为主** ✓
- B. 蛋白-细胞分离现象
- C. 细胞数增高以淋巴细胞为主
- D. 均匀血性脑脊液
- E. 脑脊液正常（相关症状）

▼  解析（答案: A）

化脓性脑膜炎脑脊液白细胞显著增高以中性粒细胞为主，蛋白增高，糖和氯化物显著降低。

batch011-M5-B1-002

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P116

蛛网膜下腔出血的脑脊液典型改变是：

- A. 细胞数增高以中性粒细胞为主
- B. 蛋白-细胞分离现象
- C. 细胞数增高以淋巴细胞为主
- **D. 均匀血性脑脊液** ✓
- E. 脑脊液正常（相关症状）

▼  解析（答案: D）

蛛网膜下腔出血腰穿可见均匀血性脑脊液，离心后上清液黄变（黄变症），可与穿刺损伤性出血鉴别。

batch011-M5-X-001

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P114

腰椎穿刺的适应证包括：

- **A. 中枢神经系统感染的诊断** ✓
- **B. 蛛网膜下腔出血的诊断** ✓
- **C. 鞘内注射药物** ✓
- **D. 测定颅内压（相关症状）** ✓
- **E. 吉兰-巴雷综合征的诊断** ✓

▼  解析（答案: A、B、C、D、E）

腰椎穿刺适应证包括诊断CNS感染、SAH、脱髓鞘疾病、GBS等；治疗性鞘内给药；测定颅内压等。

batch011-M5-X-002

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P114-P130

神经系统疾病常用的辅助检查方法包括：

- **A. 腰椎穿刺和脑脊液检查** ✓
- **B. 神经影像学检查** ✓
- **C. 神经电生理检查** ✓
- **D. 经颅多普勒超声** ✓
- **E. 神经肌肉活检** ✓

▼  解析（答案: A、B、C、D、E）

神经系统常用辅助检查包括腰椎穿刺和CSF检查、神经影像学（CT/MRI/DSA）、神经电生理、TCD和病理学检查。

batch011-M5-TF-001

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P114

腰椎穿刺术后患者应至少去枕平卧4-6小时。

- A. 正确 ☒
- B. 错误

▼  解析（答案: A）

腰穿术后至少去枕平卧4-6小时以减少低颅压头痛的发生，符合教材要求。

M6 脑血管疾病 (51题)

batch011-M6-A1-001

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P171

短暂性脑缺血发作（TIA）的好发年龄是：

- A. 20-30岁
- B. 30-40岁
- C. 40-50岁
- D. 50-70岁 ☒
- E. 70岁以上

▼  解析（答案: D）

TIA多发生于老年人（50-70岁），男性多于女性。TIA具有突发性、短暂性、可逆性特点。

batch011-M6-A1-002

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P171

TIA的临床特点不包括：

- A. 突发性
- B. 短暂性
- C. 可逆性
- D. 进行性加重 ☒
- E. 发作频率稀疏

▼ 解析（答案: D）

TIA具有突发性、短暂性、可逆性特点，发作频率通常稀疏。进行性加重是进展性卒中的特征。

batch011-M6-A1-003

| Bloom: 理解 | 难度: 中等 | 教材P173

| 需与TIA鉴别的梅尼埃病发作持续时间通常为：

- A. 数秒至数分钟
- B. 10-30分钟
- **C. 数小时（临床表现）** 
- D. 1-2天（相关症状）
- E. 数天至数周（相关症状）

▼ 解析（答案: C）

梅尼埃病表现为反复发作性眩晕伴恶心呕吐、耳鸣、耳内胀满感，每次持续数小时，而TIA症状多在数分钟至1小时内缓解。

batch011-M6-A1-004

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P175

| 脑梗死最常见的病因是：

- A. 心源性栓塞（相关症状）
- B. 血管炎（免疫性血管病变）
- C. 小动脉玻璃样变
- D. 动脉夹层（相关临床表现）
- **E. 动脉粥样硬化** 

▼ 解析（答案: E）

脑梗死最常见病因为大动脉粥样硬化，其次为心源性栓塞和小动脉闭塞（腔隙性脑梗死）。

batch011-M6-A1-005

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P178

| 大脑中动脉主干闭塞最典型的临床表现为：

- A. 闭锁综合征
- B. 纯运动性轻偏瘫
- C. 延髓背外侧综合征
- D. 基底动脉尖综合征

- E. 三偏综合征 ✓

▼  解析（答案: E）

大脑中动脉主干闭塞导致对侧偏瘫、对侧偏身感觉障碍、对侧同向性偏盲（三偏综合征）。

batch011-M6-A1-006

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P15

| 闭锁综合征的病变血管是：

- A. 大脑中动脉主干
- B. 颈内动脉（相关症状）
- C. 大脑后动脉（相关症状）
- D. 椎动脉（临床表现）
- E. 基底动脉脑桥支 ✓

▼  解析（答案: E）

闭锁综合征由基底动脉脑桥支闭塞导致脑桥基底部梗死引起，表现为四肢全瘫、不能言语、仅保留垂直眼球运动。

batch011-M6-A1-007

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P181

| 延髓背外侧综合征（Wallenberg）的病变血管是：

- A. 大脑中动脉（相关症状）
- B. 大脑前动脉（相关症状）
- C. 椎动脉或小脑后下动脉 ✓
- D. 基底动脉（相关症状）
- E. 大脑后动脉（相关症状）

▼  解析（答案: C）

延髓背外侧综合征由椎动脉或小脑后下动脉闭塞引起，表现为眩晕、同侧Horner征、交叉性感觉障碍、共济失调。

batch011-M6-A1-008

| Bloom: 分析 | 难度: 中等 | 教材P182

| 基底动脉尖综合征的特征性表现**不包括**：

- A. 眼球运动障碍
- B. 瞳孔异常
- C. 意识障碍

- D. 三偏综合征 ☒
- E. 视幻觉

▼  解析（答案: D）

基底动脉尖综合征表现为眼球运动障碍、瞳孔异常、意识障碍、视幻觉等中脑和丘脑受损症状。三偏综合征是大脑中动脉闭塞表现。

batch011-M6-A1-009

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P186

| 急性脑梗死静脉溶栓的标准时间窗为：

- A. 发病后3小时内
- B. 发病后8小时内
- C. 发病后6小时内
- D. 发病后12小时内
- E. 发病后4.5小时内 ☒

▼  解析（答案: E）

急性脑梗死静脉溶栓治疗（rt-PA）的标准时间窗为发病后4.5小时内。部分患者经影像学筛选后可延长。

batch011-M6-A1-010

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P192

| 高血压性脑出血最常见的部位是：

- A. 脑桥基底部（相关症状）
- B. 小脑半球及蚓部
- C. 基底节区壳核 ☒
- D. 脑叶（额颞顶枕叶）
- E. 脑室（侧脑室或四脑室）

▼  解析（答案: C）

高血压性脑出血最常见的部位是基底节区（壳核），约占60%。高血压主要累及豆纹动脉等深穿支动脉。

batch011-M6-A1-011

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P191

| 脑出血最常见的病因是：

- A. 脑动静脉畸形

- B. 抗凝药物使用
- C. 动脉瘤破裂（相关症状）
- D. 血液病（临床表现）
- **E. 高血压动脉硬化** 

▼  解析（答案: E）

脑出血最常见的病因是高血压伴脑小动脉硬化，约占所有脑出血的60%-70%。长期高血压导致微动脉瘤形成。

batch011-M6-A1-012

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P198

蛛网膜下腔出血最常见的病因是：

- A. 高血压（血压持续升高）
- B. 凝血功能障碍
- C. 动静脉畸形（相关症状）
- D. 外伤（头部创伤所致）
- **E. 颅内动脉瘤破裂** 

▼  解析（答案: E）

蛛网膜下腔出血最常见的病因为颅内动脉瘤破裂（约占50%-80%），其次为脑血管畸形。

batch011-M6-A1-013

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P199

蛛网膜下腔出血最具特征性的临床表现是：

- A. 偏瘫和失语
- B. 眩晕和耳鸣
- C. 缓慢进展的头痛
- **D. 突发剧烈头痛** 
- E. 昏迷和去大脑强直

▼  解析（答案: D）

蛛网膜下腔出血最具特征性的为突发剧烈头痛（患者描述为一生中最剧烈的头痛），常伴恶心呕吐、脑膜刺激征阳性。

batch011-M6-A1-014

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P168

脑血管疾病最不可干预的危险因素是：

- A. 高血压（血压持续升高）
- B. 糖尿病（血糖代谢异常）
- **C. 年龄和性别（相关症状）** ✓
- D. 吸烟（烟草有害物质）
- E. 高脂血症（相关临床表现）

▼  解析（答案: C）

不可干预因素包括年龄、性别、种族和遗传因素。高血压、糖尿病、吸烟、高脂血症均属于可干预危险因素。

batch011-M6-A1-015

| Bloom: 理解 | 难度: 中等 | 教材P194

| 脑梗死与脑出血鉴别中支持脑出血的是：

- A. 安静状态下起病
- B. TIA发作病史
- C. 症状逐渐进展加重
- **D. 活动中急性起病伴血压明显升高** ✓
- E. CT早期呈低密度改变

▼  解析（答案: D）

脑出血多在活动中或情绪激动时急性起病，常伴血压明显升高和剧烈头痛、呕吐。脑梗死多在安静状态下起病。

batch011-M6-A1-016

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P172

| TIA患者抗血小板治疗的常用药物是：

- A. 华法林（维生素K拮抗剂）
- B. 尿激酶（溶栓药物）
- C. 肝素（抗凝药物）
- **D. 阿司匹林（抗血小板聚集）** ✓
- E. 利伐沙班（相关临床表现）

▼  解析（答案: D）

TIA后应尽早启动抗血小板治疗，阿司匹林（50-325mg/d）为一线用药。华法林用于心源性栓塞的TIA患者。

batch011-M6-A1-017

| Bloom: 记忆 | 难度: 中等 | 教材P188

急性脑梗死二级预防的基础治疗**不包括**:

- A. 抗血小板治疗
- B. 他汀类药物调脂
- C. 控制血压
- **D. 溶栓治疗** ✓
- E. 控制血糖

▼  解析 (答案: D)

溶栓治疗属于急性期治疗 (一级治疗), 而非二级预防措施。二级预防包括抗血小板、他汀调脂、控制血压和血糖等。

batch011-M6-A1-018

| Bloom: 理解 | 难度: 中等 | 教材P175

大动脉粥样硬化型脑梗死的发病机制主要是:

- A. 血管痉挛导致管腔狭窄
- B. 血管先天性发育异常
- C. 血液黏稠度增高
- **D. 动脉粥样硬化斑块致血栓形成或栓塞** ✓
- E. 静脉回流障碍 (相关表现)

▼  解析 (答案: D)

大动脉粥样硬化型脑梗死主要机制为斑块破裂导致原位血栓形成, 或斑块脱落形成动脉-动脉栓塞。

batch011-M6-A1-019

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P200

确诊蛛网膜下腔出血的首选辅助检查是:

- **A. 头颅CT平扫 (相关表现)** ✓
- B. 头颅MRI (脑实质病变高分辨率成像)
- C. 腰椎穿刺 (相关临床表现)
- D. 脑血管造影 (相关症状)
- E. 经颅多普勒超声

▼  解析 (答案: A)

头颅CT平扫是诊断SAH的首选检查，急性期（发病24小时内）敏感性可达90%以上。CT阴性时行腰椎穿刺。

batch011-M6-A1-020

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P168

脑血管疾病一级预防的首要措施是：

- A. 服用阿司匹林
- B. 定期输液通血管
- C. 服用他汀类药物
- **D. 控制高血压** ✓
- E. 服用抗凝药物

▼  解析（答案: D）

高血压是脑血管疾病最重要的可干预危险因素，控制血压是一级预防的首要措施。每降低10mmHg收缩压卒中风险降低约1/3。

batch011-M6-A1-021

| Bloom: 理解 | 难度: 中等 | 教材P181

延髓背外侧综合征中Horner征的表现位于：

- A. 病变对侧（相关症状）
- B. 交替出现（相关症状）
- C. 双侧均出现（相关症状）
- **D. 病变同侧（相关症状）** ✓
- E. 不出现Horner征

▼  解析（答案: D）

延髓背外侧综合征中Horner征位于病变同侧，由下行的交感神经纤维受损所致，表现为眼裂缩小、瞳孔缩小、面部无汗。

batch011-M6-A1-022

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P201

蛛网膜下腔出血后脑血管痉挛最常发生在：

- A. 出血后1-2天内
- B. 出血后3-14天
- C. 出血后2-3周
- **D. 出血后1个月** ✓

- E. 任何时间均可发生

▼  解析（答案: D）

脑血管痉挛通常在出血后3-5天开始，7-10天达高峰，持续2周左右。可导致迟发性脑缺血和神经功能恶化。

batch011-M6-A2-001

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P171

患者男，60岁，突发左侧肢体无力伴言语不清10分钟，症状完全消失。既往高血压病史。最可能的诊断是：

- A. 脑梗死（缺血性脑卒中）
- B. 脑出血（高血压性颅内出血）
- **C. 短暂性脑缺血发作** 
- D. 癫痫部分性发作
- E. 偏头痛发作（相关症状）

▼  解析（答案: C）

突发局灶性神经功能缺损（左侧肢体无力+言语不清），10分钟内完全缓解，符合TIA的诊断标准。TIA症状通常在1小时内完全恢复。

batch011-M6-A2-002

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P178

患者男，70岁，晨起发现右侧肢体**不能**活动4小时。查体：右侧中枢性面瘫，右侧肢体肌力1级，Babinski征阳性，运动性失语。最可能的诊断是：

- A. 脑出血（高血压性颅内出血）
- **B. 左侧大脑中动脉区脑梗死** 
- C. 脑干梗死（椎-基底动脉系统闭塞）
- D. 右侧大脑中动脉区脑梗死
- E. 蛛网膜下腔出血（SAH，动脉瘤破裂常见）

▼  解析（答案: B）

右侧偏瘫+右侧偏身感觉障碍+运动性失语（优势半球），安静状态下起病，符合左侧大脑中动脉区脑梗死的典型三偏综合征。

batch011-M6-A2-003

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P192

患者男，55岁，活动中突发头痛呕吐右侧肢体无力2小时。查体：血压190/110mmHg，右侧中枢性面瘫，右侧肢体肌力0级。最可能的诊断是：

- A. 脑梗死（缺血性脑卒中）
- **B. 脑出血（高血压性颅内出血）** 
- C. 蛛网膜下腔出血（SAH，动脉瘤破裂常见）
- D. 短暂性脑缺血发作（TIA）
- E. 偏头痛发作（相关症状）

▼  解析（答案: B）

活动中急性起病、血压明显升高、头痛呕吐+局灶性神经功能缺损，高度提示高血压性脑出血。

batch011-M6-A2-004

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P199-P200

患者女，45岁，突发炸裂样头痛伴恶心呕吐1小时。查体：颈强直阳性，Kernig征阳性，无明显肢体瘫痪。头颅CT示鞍上池高密度影。最可能的诊断是：

- A. 脑出血（高血压性颅内出血）
- B. 脑梗死（缺血性脑卒中）
- **C. 蛛网膜下腔出血（SAH，动脉瘤破裂常见）** 
- D. 脑膜炎（软脑膜弥漫性炎症）
- E. 偏头痛发作（相关症状）

▼  解析（答案: C）

突发炸裂样头痛+脑膜刺激征阳性+CT示脑池高密度影，无肢体瘫痪，符合蛛网膜下腔出血的典型表现。

batch011-M6-A2-005

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P15

患者男，65岁，突发四肢瘫痪不能言语2天。查体：神志清楚，仅保留垂直眼球运动，双侧面瘫，四肢全瘫。最可能的诊断是：

- A. 大面积脑梗死伴昏迷
- **B. 闭锁综合征（相关症状）** 
- C. 吉兰-巴雷综合征（GBS，脱髓鞘）
- D. 重症肌无力危象
- E. 脑干出血伴昏迷

▼  解析（答案: B）

患者神志清楚但四肢全瘫、双侧面瘫、不能讲话，仅保留垂直眼球运动，符合闭锁综合征。病因为基底动脉脑桥支闭塞。

batch011-M6-A2-006

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P181

患者男，58岁，突发眩晕恶心呕吐声音嘶哑半天。查体：右侧Horner征阳性，右侧面部及左侧肢体痛温觉减退，右侧肢体指鼻试验不准。最可能的诊断是：

- A. 小脑出血（相关临床表现）
- **B. 延髓背外侧综合征** ✓
- C. 大脑中动脉区梗死
- D. 脑桥梗死（相关临床表现）
- E. 前庭神经炎（病毒感染致急性眩晕）

▼  解析（答案: B）

同侧Horner征+同侧面面部痛温觉减退+对侧肢体痛温觉减退+同侧共济失调，为延髓背外侧综合征（Wallenberg）的典型五联征。

batch011-M6-A2-007

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P172

患者女，55岁，反复发作性左侧肢体麻木无力，每次持续约15分钟共发作3次。查体无异常。MRI未见急性梗死灶。最合理的处理是：

- A. 无需处理继续观察
- **B. 给予抗血小板治疗并控制危险因素** ✓
- C. 立即静脉溶栓（相关表现）
- D. 给予抗凝治疗（相关表现）
- E. 给予脱水降颅压治疗

▼  解析（答案: B）

患者表现符合TIA，TIA是脑梗死的预警信号，应给予抗血小板治疗（阿司匹林）和积极控制危险因素以预防卒中。

batch011-M6-A2-008

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P186

患者男，72岁，突发右侧肢体无力2小时。CT未见出血。NIHSS评分12分。既往无特殊病史。最合适的治疗是：

- A. 立即抗血小板治疗
- **B. 静脉溶栓治疗** ✓
- C. 急诊血管内介入治疗
- D. 抗凝治疗（相关症状）

- E. 对症支持治疗

▼ 解析（答案: B）

发病2小时在4.5小时溶栓时间窗内，CT已排除出血，NIHSS 12分为中-重度卒中，无溶栓禁忌证，应行静脉溶栓。

batch011-M6-A2-009

| Bloom: 分析 | 难度: 中等 | 教材P185

患者男，70岁，晨起右侧肢体活动不利6小时。既往高血压糖尿病史。查体：BP150/90mmHg，神志清楚，右侧中枢性面瘫，右侧肢体肌力3级。首选检查是：

- **A. 头颅CT平扫（相关表现）** 
- B. 头颅MRI（脑实质病变高分辨率成像）
- C. 脑血管造影（相关症状）
- D. 脑电图（EEG，大脑电活动记录）
- E. 腰椎穿刺（相关临床表现）

▼ 解析（答案: A）

患者安静状态下起病，神经功能缺损明确，需首先鉴别缺血性和出血性卒中。头颅CT平扫可快速区分脑出血和脑梗死，是急诊首选检查。

batch011-M6-A2-010

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P201

患者女，50岁，SAH后第8天出现意识水平下降、右侧肢体无力。最可能的原因是：

- A. 再出血（动脉瘤再次破裂）
- **B. 脑血管痉挛（相关症状）** 
- C. 急性脑积水（相关症状）
- D. 癫痫发作后状态
- E. 低钠血症（相关临床表现）

▼ 解析（答案: B）

SAH后3-14天为脑血管痉挛高发期，第7-10天达高峰。出血后第8天出现意识下降和局灶神经功能缺损，高度提示脑血管痉挛导致迟发性脑缺血。

batch011-M6-A2-011

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P195

患者男，60岁，脑出血后第2天血压180/105mmHg。最恰当的处理是：

- A. 立即将血压降至正常水平

- **B. 缓慢降压维持血压在合理范围** ☒
- C. 不予降压处理（相关表现）
- D. 给予强效利尿剂快速降压
- E. 仅通过限制钠盐摄入降压

▼  解析（答案: B）

脑出血急性期血压管理应谨慎，过度降压可能降低脑灌注压加重脑缺血。应缓慢平稳降压，避免血压剧烈波动。

batch011-M6-A2-012

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P183

患者男，58岁，高血压史10年，突发右侧肢体纯运动性轻偏瘫，无感觉障碍、无失语、无视物异常。最可能的诊断是：

- A. 大脑中动脉区脑梗死
- **B. 腔隙性脑梗死（相关表现）** ☒
- C. 脑出血（高血压性颅内出血）
- D. 脑干梗死（椎-基底动脉系统闭塞）
- E. 短暂性脑缺血发作

▼  解析（答案: B）

高血压患者出现纯运动性轻偏瘫（仅累及运动功能），符合腔隙性脑梗死的典型临床表现。由深穿支小动脉闭塞引起。

batch011-M6-A3-001

| Bloom: 分析 | 难度: 中等 | 教材P200

患者女，48岁，突发剧烈头痛恶心呕吐1小时。查体：颈强直阳性，Kernig征阳性。BP170/95mmHg。首选检查是：

- **A. 头颅CT平扫（相关表现）** ☒
- B. 头颅MRI（脑实质病变高分辨率成像）
- C. 脑血管造影（相关症状）
- D. 腰椎穿刺（相关临床表现）
- E. 经颅多普勒超声

▼  解析（答案: A）

突发剧烈头痛+脑膜刺激征阳性，高度怀疑SAH。头颅CT平扫是快速诊断SAH的首选检查，急性期敏感性高。

batch011-M6-A3-002

| Bloom: 分析 | 难度: 中等 | 教材P200

头颅CT示鞍上池及侧裂池高密度影。下一步最重要的检查是：

- A. 脑电图（EEG，大脑电活动记录）
- **B. 脑血管造影检查** ✓
- C. 头颅MRI平扫
- D. 腰椎穿刺复查（相关表现）
- E. 颅内压监测（相关症状）

▼  解析（答案: B）

确诊SAH后需进一步行脑血管造影（DSA为金标准）或CTA以明确动脉瘤位置、大小和形态，为后续治疗提供依据。

batch011-M6-A3-003

| Bloom: 分析 | 难度: 中等 | 教材P201

该患者住院第10天突然再次剧烈头痛，意识由清醒转为嗜睡。最可能的诊断是：

- A. 脑血管痉挛
- **B. 再次出血** ✓
- C. 急性脑积水
- D. 癫痫发作
- E. 低钠血症脑病

▼  解析（答案: B）

动脉瘤性SAH再出血最常发生在首次出血后24小时内和第7-10天。突然再次剧烈头痛+意识水平下降，高度提示动脉瘤再次破裂出血。

batch011-M6-A3-004

| Bloom: 分析 | 难度: 中等 | 教材P185

患者男，68岁，突发左侧肢体无力2.5小时来急诊。既往房颤史5年未规律抗凝。左侧中枢性面瘫，左侧肢体肌力2级。NIHSS评分10分。首先应：

- **A. 立即头颅CT平扫** ✓
- B. 立即给予华法林
- C. 立即静脉溶栓
- D. 立即脑血管造影
- E. 立即抗血小板治疗

▼  解析（答案: A）

首先需行急诊头颅CT平扫排除脑出血，明确是否为缺血性卒中。在CT结果出来前不能启动溶栓或抗凝/抗血小板治疗。

batch011-M6-A3-005

| Bloom: 分析 | 难度: 中等 | 教材P186

头颅CT未见出血和早期梗死征象。该患者最合适的急性期治疗是：

- A. 抗血小板治疗
- **B. 静脉溶栓治疗** ✓
- C. 急诊血管内取栓
- D. 立即华法林抗凝治疗
- E. 仅对症支持治疗

▼  解析（答案: B）

发病2.5小时在4.5小时时间窗内，CT排除出血，NIHSS 10分为中重度卒中，无溶栓禁忌证，符合静脉溶栓适应证。

batch011-M6-A3-006

| Bloom: 分析 | 难度: 中等 | 教材P188

溶栓24小时后该房颤患者应开始长期二级预防，首选的抗栓策略是：

- A. 阿司匹林长期口服
- B. 氯吡格雷长期口服
- C. 阿司匹林联合氯吡格雷
- **D. 口服抗凝药华法林或新型抗凝药** ✓
- E. 无需抗栓治疗（相关表现）

▼  解析（答案: D）

心房颤动是心源性栓塞的主要病因，口服抗凝药（华法林或新型口服抗凝药）是房颤患者卒中二级预防的首选。

batch011-M6-B1-001

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P178

表现为对侧偏瘫、对侧偏身感觉障碍、对侧同向性偏盲的是：

- **A. 大脑中动脉主干闭塞** ✓
- B. 基底动脉脑桥支闭塞
- C. 椎动脉闭塞
- D. 大脑前动脉闭塞

- E. 小脑后下动脉闭塞

▼  解析（答案: A）

大脑中动脉主干闭塞导致内囊和大脑半球外侧面的广泛缺血，出现经典的三偏综合征。

batch011-M6-B1-002

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P15

| 表现为四肢全瘫**不能**言语仅保留垂直眼球运动的是：

- A. 大脑中动脉主干闭塞
- B. 大脑前动脉闭塞
- C. 椎动脉闭塞
- **D. 基底动脉脑桥支闭塞** 
- E. 小脑后下动脉闭塞

▼  解析（答案: D）

基底动脉脑桥支闭塞导致脑桥基底部梗死，出现闭锁综合征：四肢全瘫、双侧面瘫、不能言语，仅保留垂直眼球运动。

batch011-M6-B1-003

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P181

| 表现为眩晕同侧Horner征交叉性感觉障碍同侧共济失调的是：

- A. 大脑中动脉主干闭塞
- B. 基底动脉脑桥支闭塞
- C. 椎动脉闭塞
- D. 大脑前动脉闭塞
- **E. 小脑后下动脉闭塞** 

▼  解析（答案: E）

小脑后下动脉或椎动脉闭塞导致延髓背外侧综合征，表现为眩晕、同侧Horner征、交叉性感觉障碍、同侧共济失调。

batch011-M6-X-001

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P178

| 大脑中动脉主干闭塞的三偏综合征包括：

- **A. 对侧偏瘫（相关症状）** 
- **B. 对侧偏身感觉障碍** 
- **C. 对侧同向性偏盲** 

- D. 同侧Horner征
- E. 垂直性眼球震颤

▼  解析（答案: A、B、C）

大脑中动脉主干闭塞的三偏综合征为对侧偏瘫（皮质脊髓束）、对侧偏身感觉障碍（丘脑中央辐射）和对侧同向性偏盲（视辐射）。

batch011-M6-X-002

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P168

| 以下属于脑血管疾病可干预危险因素的是：

- A. 高血压（血压持续升高） 
- B. 糖尿病（血糖代谢异常） 
- C. 吸烟（烟草有害物质） 
- D. 高脂血症（相关临床表现） 
- E. 心房颤动（相关临床表现） 

▼  解析（答案: A、B、C、D、E）

脑血管疾病可干预危险因素包括高血压、糖尿病、吸烟、高脂血症、心房颤动、颈动脉狭窄、肥胖、缺乏体力活动等。

batch011-M6-X-003

| Bloom: 理解 | 难度: 中等 | 教材P181

| 延髓背外侧综合征（Wallenberg）的临床表现包括：

- A. 眩晕恶心呕吐（相关表现） 
- B. 同侧Horner征 
- C. 交叉性感觉障碍（一侧面部+对侧肢体感觉异常） 
- D. 同侧肢体共济失调 
- E. 声音嘶哑吞咽困难 

▼  解析（答案: A、B、C、D、E）

延髓背外侧综合征五大核心表现：眩晕恶心呕吐（前庭核）、同侧Horner征（交感纤维）、交叉性感觉障碍、同侧共济失调（绳状体）、声音嘶哑吞咽困难（疑核）。

batch011-M6-X-004

| Bloom: 理解 | 难度: 中等 | 教材P201-P202

| 蛛网膜下腔出血的常见并发症包括：

- A. 再出血（动脉瘤再次破裂） 

- B. 脑血管痉挛（相关症状） ✓
- C. 急性脑积水（相关症状） ✓
- D. 低钠血症（相关临床表现） ✓
- E. 癫痫发作（相关临床表现） ✓

▼  解析（答案: A、B、C、D、E）

SAH常见并发症包括再出血、脑血管痉挛（迟发性脑缺血）、急性或迟发性脑积水、低钠血症和癫痫发作等。

batch011-M6-X-005

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P194

| 支持脑出血而非脑梗死的临床特点包括：

- A. 活动中急性起病 ✓
- B. 血压明显升高 ✓
- C. 早期出现剧烈头痛和呕吐 ✓
- D. 意识障碍出现早且重 ✓
- E. 安静状态下起病

▼  解析（答案: A、B、C、D）

脑出血多在活动中起病，血压明显升高，伴头痛、呕吐和意识障碍。脑梗死多在安静状态下起病，意识障碍相对少见且较轻。

batch011-M6-TF-001

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P171

| 短暂性脑缺血发作（TIA）的症状通常在24小时内完全恢复。

- A. 正确 ✓
- B. 错误

▼  解析（答案: A）

传统定义中TIA的神经功能缺损症状在24小时内完全恢复，且不遗留神经功能缺损体征。多数TIA在1小时内缓解。

batch011-M6-TF-002

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P192

| 高血压性脑出血最常见的部位是小脑。

- A. 正确
- B. 错误 ✓

▼ 解析（答案: B）

高血压性脑出血最常见的部位是基底节区（壳核），约占60%，其次为丘脑、脑桥、小脑和脑叶。

batch011-M6-TF-003

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P198

蛛网膜下腔出血最常见的病因是颅内动脉瘤破裂。

- A. 正确 
- B. 错误

▼ 解析（答案: A）

颅内动脉瘤破裂是蛛网膜下腔出血最常见的病因，占SAH的50%-80%。

M7 运动障碍性疾病 (18题)

batch011-M7-A1-001

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P284

帕金森病的主要病理改变是：

- A. 黑质多巴胺能神经元变性缺失 
- B. 纹状体乙酰胆碱能神经元变性
- C. 大脑皮质神经元广泛脱失
- D. 小脑浦肯野细胞变性
- E. 脊髓前角运动神经元变性

▼ 解析（答案: A）

帕金森病的主要病理改变是黑质致密部多巴胺能神经元变性缺失，导致纹状体多巴胺含量显著减少。

batch011-M7-A1-002

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P284

帕金森病的四大核心临床特征**不包括**：

- A. 静止性震颤
- B. 运动迟缓
- C. 肌强直

- **D. 感觉障碍** 
- E. 姿势平衡障碍

▼  解析（答案: D）

帕金森病四大核心临床特征为静止性震颤、运动迟缓、肌强直和姿势平衡障碍。感觉障碍不是PD的核心特征。

batch011-M7-A1-003

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P285

帕金森病震颤的特征是：

- A. 动作性震颤
- B. 体位性震颤
- C. 意向性震颤
- **D. 静止性震颤** 
- E. 扑翼样震颤

▼  解析（答案: D）

帕金森病的震颤为静止性震颤，肢体静止时出现、随意运动时减轻或消失、紧张时加重、睡眠时消失。

batch011-M7-A1-004

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P285

帕金森病肌强直的特征性表现是：

- **A. 铅管样或齿轮样肌强直** 
- B. 折刀样肌强直
- C. 痉挛性肌强直
- D. 间歇性肌强直
- E. 肌张力降低

▼  解析（答案: A）

帕金森病肌强直表现为铅管样（均匀阻力）或齿轮样（阻力断续）肌强直，区别于上运动神经元瘫痪的折刀样肌强直。

batch011-M7-A1-005

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P289

帕金森病治疗的金标准药物是：

- A. 苯海索（抗胆碱能药）

- B. 金刚烷胺（相关临床表现）
- **C. 左旋多巴（多巴胺前体药物）** 
- D. 普拉克索（相关临床表现）
- E. 司来吉兰（相关临床表现）

▼  解析（答案: C）

左旋多巴是帕金森病治疗的金标准药物，可补充脑内多巴胺不足，对运动迟缓、肌强直和震颤均有良好疗效。

batch011-M7-A1-006

| Bloom: 记忆 | 难度: 中等 | 教材P290

帕金森病早期治疗的首选策略是：

- A. 立即使用左旋多巴
- B. 仅用抗胆碱能药物
- C. 立即行DBS手术
- **D. 延迟使用左旋多巴优先选用多巴胺受体激动剂** 
- E. 观察等待不治疗

▼  解析（答案: D）

帕金森病早期治疗原则为延迟左旋多巴使用，优先选用多巴胺受体激动剂或MAO-B抑制剂，以延缓运动并发症的发生。

batch011-M7-A1-007

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P290

脑深部电刺激（DBS）最常选择的手术靶点是：

- A. 丘脑腹中间核
- B. 红核（中脑结构）
- C. 黑质致密部（相关症状）
- **D. 苍白球内侧部和丘脑底核** 
- E. 纹状体（壳核苍白球）

▼  解析（答案: D）

DBS因其相对微创、安全和可调控性作为主要手术选择。手术靶点包括苍白球内侧部（GPi）和丘脑底核（STN）。

batch011-M7-A1-008

| Bloom: 理解 | 难度: 中等 | 教材P288

帕金森病与抑郁症鉴别时支持帕金森病的是：

- A. 无肌强直和震颤
- B. 随意运动减少但无运动迟缓
- C. 表情贫乏但言语速度正常
- **D. 症状限于一侧肢体** ✓
- E. 抗抑郁治疗后症状完全消失

▼  解析（答案: D）

早期帕金森病症状常限于一侧肢体，而抑郁症可伴表情贫乏和随意运动减少但无肌强直和震颤。单侧起病是PD的重要特征。

batch011-M7-A1-009

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P284

帕金森病又名：

- A. 亨廷顿病（CAG重复扩增的遗传性舞蹈病）
- B. 肝豆状核变性（Wilson病）
- **C. 震颤麻痹（相关临床表现）** ✓
- D. 扭转痉挛（相关临床表现）
- E. 手足徐动症（缓慢扭动样不自主运动）

▼  解析（答案: C）

帕金森病（Parkinson disease, PD）又名震颤麻痹（paralysis agitans），常见于中老年的神经系统变性疾病。

batch011-M7-A2-001

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P285

患者男，62岁，右上肢不自主抖动伴动作缓慢2年。查体：右手静止性震颤，右上肢肌张力齿轮样增高，行走时右上肢联合运动消失。最可能的诊断是：

- A. 特发性震颤（相关症状）
- **B. 帕金森病（黑质多巴胺神经元变性）** ✓
- C. 肝豆状核变性（Wilson病）
- D. 多系统萎缩（相关症状）
- E. 亨廷顿病（CAG重复扩增的遗传性舞蹈病）

▼  解析（答案: B）

中老年男性，单侧起病的静止性震颤+齿轮样肌强直+运动迟缓+联合运动消失，符合帕金森病的典型核心临床表现。

batch011-M7-A2-002

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P292

患者女，65岁，帕金森病史5年长期服用左旋多巴。近半年来出现服药后不自主舞蹈样动作（剂峰异动症）。最合适的处理是：

- A. 增加左旋多巴剂量
- **B. 减少每次左旋多巴剂量或加用COMT抑制剂** ✓
- C. 立即停用左旋多巴
- D. 加用抗胆碱能药物
- E. 无需处理继续观察

▼  解析（答案: B）

左旋多巴的剂峰异动症可通过减少每次剂量、增加服药频率或加用COMT抑制剂（如恩他卡朋）来改善。

batch011-M7-A2-003

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P288

患者男，55岁，右上肢不灵活半年就诊。查体：右上肢肌张力轻度增高，无震颤。易被误诊为的疾病是：

- A. 周围神经病变
- **B. 脑血管病** ✓
- C. 颈椎病
- D. 脊髓病变
- E. 运动神经元病

▼  解析（答案: B）

早期帕金森病症状限于一侧肢体时易被误诊为脑血管病。但脑血管病通常急性起病且有其他神经系统体征。

batch011-M7-A3-001

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P285

患者男，60岁，右上肢不自主抖动伴动作缓慢2年。查体：右手静止性震颤（4-6Hz），右上肢肌张力呈齿轮样增高，行走时右臂联合运动消失。最可能的诊断是：

- A. 特发性震颤（相关症状）
- **B. 帕金森病（黑质多巴胺神经元变性）** ✓
- C. 脑血管病后遗症
- D. 肝豆状核变性（Wilson病）

- E. 多系统萎缩（相关症状）

▼ 解析（答案: B）

中老年、单侧起病、静止性震颤+齿轮样肌强直+运动迟缓+联合运动消失，符合帕金森病核心诊断标准。

batch011-M7-A3-002

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P290

| 该患者早期治疗的合理选择是：

- A. 立即使用左旋多巴制剂
- **B. 多巴胺受体激动剂或MAO-B抑制剂** 
- C. 立即行脑深部电刺激手术
- D. 仅使用抗胆碱能药物
- E. 观察等待不治疗

▼ 解析（答案: B）

帕金森病早期治疗原则为延迟左旋多巴使用，优先选用多巴胺受体激动剂或MAO-B抑制剂，以延缓运动并发症发生。

batch011-M7-A3-003

| Bloom: 分析 | 难度: 中等 | 教材P292

| 若该患者左旋多巴治疗5年后出现剂末现象和剂峰异动症，合理的处理是：

- A. 增加左旋多巴单次剂量
- **B. 减少每次剂量或加用COMT抑制剂** 
- C. 立即停用左旋多巴
- D. 换用抗胆碱能药物
- E. 无需调整继续用药

▼ 解析（答案: B）

剂峰异动症可通过减少每次左旋多巴剂量、增加服药频率或加用COMT抑制剂（如恩他卡朋）来改善。

batch011-M7-X-001

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P284

| 帕金森病的核心临床特征包括：

- **A. 静止性震颤** 
- **B. 运动迟缓** 

- C. 肌强直 ☒
- D. 姿势平衡障碍 ☒
- E. 感觉障碍

▼  解析（答案: A、B、C、D）

帕金森病四大核心临床特征为静止性震颤、运动迟缓、肌强直和姿势平衡障碍。感觉障碍非PD核心特征。

batch011-M7-X-002

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P289-P292

| 帕金森病的治疗药物包括：

- A. 左旋多巴 ☒
- B. 多巴胺受体激动剂 ☒
- C. MAO-B抑制剂 ☒
- D. COMT抑制剂 ☒
- E. 抗胆碱能药物 ☒

▼  解析（答案: A、B、C、D、E）

帕金森病药物治疗包括左旋多巴制剂、多巴胺受体激动剂、MAO-B抑制剂、COMT抑制剂和抗胆碱能药物五大类。

batch011-M7-TF-001

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P285

| 帕金森病的震颤属于意向性震颤，运动时加重。

- A. 正确
- B. 错误 ☒

▼  解析（答案: B）

帕金森病震颤为静止性震颤，静止时出现而随意运动时减轻或消失。意向性震颤是小脑性共济失调的特征。

M8 癫痫 (31题)

batch011-M8-A1-001

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P307

| 以下属于全面性发作的是：

- A. 单纯部分性发作
- B. 复杂部分性发作
- **C. 失神发作（短暂意识丧失不伴跌倒）** ✓
- D. 部分性继发全面性发作
- E. Jackson发作

▼  解析（答案: C）

癫痫全面性发作包括强直-阵挛、强直、阵挛、失神、失张力、肌阵挛发作。单纯部分性、复杂部分性为部分性发作类型。

batch011-M8-A1-002

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P310

儿童良性癫痫伴中央颞区棘波的发作为：

- A. 全面性强直阵挛发作为主
- B. 肌阵挛发作（快速短暂肌肉收缩）
- C. 失神发作（短暂意识丧失不伴跌倒）
- **D. 局灶性发作或夜间双侧强直阵挛发作** ✓
- E. 复杂部分性发作

▼  解析（答案: D）

儿童良性癫痫伴中央颞区棘波主要表现为局灶性发作和/或夜间双侧强直-阵挛发作，每次2-3分钟，通常13岁前自行消失。

batch011-M8-A1-003

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P308

全面性强直-阵挛发作（GTCS）的主要特征是：

- A. 意识保留伴局部抽搐
- B. 肌张力突然丧失导致跌倒
- C. 短暂意识障碍但无抽搐
- **D. 意识丧失后双侧强直继而阵挛** ✓
- E. 单侧肢体阵挛性抽搐

▼  解析（答案: D）

GTCS以意识丧失、双侧强直后出现阵挛为主要特征，分为强直期、阵挛期和发作后期三个阶段。

batch011-M8-A1-004

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P308

| Jackson发作（部分运动性发作）的特点为：

- A. 双侧对称性抽搐
- B. 意识完全丧失（相关表现）
- C. 仅表现为感觉异常
- **D. 抽搐从局部开始沿皮质运动区顺序扩展** ✓
- E. 全身肌张力丧失

▼  解析（答案: D）

Jackson发作的抽搐从一侧手指或足趾开始，沿大脑皮质运动区分布顺序扩展至邻近部位，发作时意识保留。

batch011-M8-A1-005

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P311

| 癫痫诊断最重要的辅助检查是：

- A. 头颅CT（急性出血首选影像检查）
- B. 头颅MRI（脑实质病变高分辨率成像）
- **C. 脑电图（EEG，大脑电活动记录）** ✓
- D. 腰椎穿刺（相关临床表现）
- E. 脑血管造影（相关症状）

▼  解析（答案: C）

脑电图（EEG）是癫痫诊断最重要的辅助检查，可记录到癫痫样放电（棘波、尖波、棘慢复合波等）。

batch011-M8-A1-006

| Bloom: 理解 | 难度: 中等 | 教材P69

| 癫痫发作与晕厥的鉴别要点中支持晕厥的是：

- A. 发作间期脑电图异常
- B. 有神经系统定位体征
- **C. 发作间期脑电图多正常** ✓
- D. 发作后意识模糊持续时间长
- E. 发作时常有咬舌和尿失禁

▼  解析（答案: C）

晕厥发作间期脑电图多正常且心血管系统异常常见；癫痫发作间期脑电图异常常见，可有神经系统定位体征。

batch011-M8-A1-007

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P315

癫痫持续状态的定义是：

- A. 发作持续15分钟
- B. 持续超过30分钟或反复发作间歇期意识未恢复
- **C. 单次发作持续20分钟** ✓
- D. 发作伴意识障碍
- E. 持续超过10分钟

▼  解析（答案: C）

癫痫持续状态是指癫痫发作持续超过30分钟，或反复发作且发作间歇期意识未恢复至基线水平，属于神经科急症。

batch011-M8-A1-008

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P315

癫痫持续状态的一线治疗药物是：

- A. 苯妥英钠（相关临床表现）
- B. 丙戊酸钠（广谱抗癫痫药物）
- **C. 地西泮（苯二氮䓬类，癫痫持续状态首选）** ✓
- D. 卡马西平（相关临床表现）
- E. 苯巴比妥（巴比妥类抗癫痫药物）

▼  解析（答案: C）

地西泮（安定）是癫痫持续状态的一线治疗药物，静脉推注起效快。如未能控制可选用苯妥英钠、丙戊酸钠等二线药物。

batch011-M8-A1-009

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P306

以下哪项**不是**癫痫发作的常见诱因？

- A. 睡眠剥夺
- B. 情绪激动
- C. 闪光刺激
- **D. 规律服药** ✓

- E. 饮酒

▼ 解析（答案: D）

癫痫发作的常见诱因包括睡眠剥夺、情绪激动、闪光刺激、饮酒、发热、过度换气等。规律服药是预防发作的措施而非诱因。

batch011-M8-A1-010

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P311

癫痫诊断中视频脑电图的优势**不包括**：

- A. 提高痫样放电检出率
- B. 同步记录发作期临床表现和脑电变化
- C. 可用于发作类型的分类
- **D. 可替代影像学检查** 
- E. 有助于鉴别癫痫性与非癫痫性发作

▼ 解析（答案: D）

视频脑电图可提高检出率、同步记录临床和脑电、辅助发作分类和鉴别诊断，但不能替代影像学检查（MRI用于寻找癫痫病因）。

batch011-M8-A1-011

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P308

典型失神发作的特征是：

- A. 意识丧失伴全身抽搐
- B. 意识保留伴局部抽搐
- **C. 短暂意识障碍但无抽搐** 
- D. 肌张力丧失致突然跌倒
- E. 发作后长时间意识模糊

▼ 解析（答案: C）

典型失神发作表现为短暂意识障碍（数秒至十几秒），突然发生和终止，无抽搐，脑电图呈3Hz棘慢复合波。

batch011-M8-A1-012

| Bloom: 理解 | 难度: 中等 | 教材P315

癫痫持续状态控制发作后为防止复发应选用：

- A. 继续静脉用地西洋维持
- B. 立即停用所有药物

- C. 口服或鼻饲抗癫痫药物维持 ☒
- D. 仅对症支持不需要药物
- E. 激素冲击治疗

▼  解析（答案: C）

癫痫持续状态控制后应给予口服或鼻饲抗癫痫药物维持，防止复发。同时需寻找和处理导致持续状态的病因和诱因。

batch011-M8-A1-013

| Bloom: 理解 | 难度: 中等 | 教材P307

复杂部分性发作与单纯部分性发作的主要区别在于：

- A. 有无运动症状
- B. 有无感觉异常
- C. 有无意识障碍 ☒
- D. 有无自主神经症状
- E. 发作持续时间长短

▼  解析（答案: C）

单纯部分性发作意识保留，复杂部分性发作伴意识障碍。这是两者最关键的鉴别点。复杂部分性发作常起源于颞叶。

batch011-M8-A2-001

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P308

患者男，25岁，突发意识丧失倒地全身强直后出现阵挛性抽搐，伴口吐白沫面色发绀，持续约3分钟。最可能的诊断是：

- A. 晕厥（短暂脑缺血缺氧）
- B. 全面性强直-阵挛发作 ☒
- C. 癔症性发作（相关症状）
- D. 复杂部分性发作
- E. 短暂性脑缺血发作

▼  解析（答案: B）

典型GTCS表现为意识丧失→强直→阵挛→发作后状态，持续2-3分钟，伴口吐白沫和发绀。

batch011-M8-A2-002

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P308

患者女，30岁，发作性右侧拇指抽搐开始逐渐扩展至右手、右前臂、右上臂、右侧面部，每次约2分钟，发作时意识清楚。该发作类型是：

- A. 全面性强直阵挛发作
- B. 复杂部分性发作
- **C. 部分运动性发作（Jackson发作）** ✓
- D. 失神发作（短暂意识丧失不伴跌倒）
- E. 肌阵挛发作（快速短暂肌肉收缩）

▼  解析（答案: C）

抽搐从一侧拇指开始沿皮质运动区顺序扩展，发作时意识保留，符合Jackson发作（部分运动性发作）的典型特征。

batch011-M8-A2-003

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P315

患者男，40岁，癫痫病史10年。今日突然频繁发作连续抽搐30分钟，发作间歇期意识未恢复。最可能的诊断是：

- A. 癫痫发作频率增加
- **B. 癫痫持续状态** ✓
- C. 药物难治性癫痫
- D. 假性发作
- E. 撤药性发作

▼  解析（答案: B）

癫痫发作持续超过30分钟且发作间歇期意识未恢复，符合癫痫持续状态的诊断标准，属于神经科急症。

batch011-M8-A2-004

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P69

患者女，22岁，站立时突然意识丧失倒地约1分钟后自行清醒，无抽搐无咬舌无尿失禁。发作间期脑电图正常。最可能的诊断是：

- A. 癫痫全面性发作
- **B. 晕厥（短暂脑缺血缺氧）** ✓
- C. 癔症性发作（相关症状）
- D. 短暂性脑缺血发作
- E. 低血糖发作（相关症状）

▼  解析（答案: B）

短暂意识丧失、站立位诱发、无抽搐和咬舌、发作间期脑电图正常，更支持血管迷走性晕厥的诊断。

batch011-M8-A2-005

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P310

患儿男，9岁，夜间睡眠中出现口角抽动流涎喉中发声，有时发展为全身抽搐，每次2-3分钟。脑电图示中央颞区棘波。最可能的诊断是：

- A. 全面性癫痫（相关症状）
- **B. 儿童良性癫痫伴中央颞区棘波** ✓
- C. 少年肌阵挛癫痫
- D. Lennox-Gastaut综合征
- E. 额叶癫痫（发作短暂频繁易丛集）

▼  解析（答案: B）

学龄期儿童、夜间局灶性发作可继发全面性、发作间期正常、脑电图示中央颞区棘波，符合儿童良性癫痫伴中央颞区棘波的典型表现。

batch011-M8-A3-001

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P308

患者男，25岁，反复发作性意识障碍3年。每次发作表现为意识丧失倒地、全身强直后阵挛性抽搐，伴口吐白沫面色发绀，持续约3分钟。最可能的诊断是：

- A. 晕厥发作（相关症状）
- **B. 全面性强直-阵挛发作** ✓
- C. 复杂部分性发作
- D. 癔症性发作（相关症状）
- E. 短暂性脑缺血发作

▼  解析（答案: B）

意识丧失+双侧强直-阵挛+口吐白沫+发作后状态，是全面性强直-阵挛发作（GTCS）的典型表现。

batch011-M8-A3-002

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P311

该患者最有助于确诊的辅助检查是：

- A. 头颅CT平扫
- **B. 脑电图（常规和长程监测）** ✓

- C. 头颅MRI平扫
- D. 腰椎穿刺脑脊液检查
- E. 脑血管造影检查

▼  解析（答案: B）

脑电图是癫痫诊断最重要的辅助检查，发作间期痫样放电是支持癫痫诊断的重要依据。

batch011-M8-A3-003

| Bloom: 分析 | 难度: 中等 | 教材P315

若该患者今日频繁发作连续抽搐超30分钟且间歇期意识未恢复，首选处理是：

- A. 口服卡马西平片
- **B. 静脉注射地西泮并保证呼吸支持** 
- C. 肌肉注射苯巴比妥钠
- D. 口服丙戊酸钠缓释片
- E. 观察等待自行停止

▼  解析（答案: B）

癫痫持续状态（发作>30min或间歇期意识未恢复）是神经科急症。一线治疗为静脉注射地西泮，同时保证呼吸道通畅和呼吸支持。

batch011-M8-B1-001

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P308

意识保留抽搐从一侧手指开始逐渐扩展至同侧肢体的是：

- A. 全面性强直阵挛发作
- **B. 单纯部分性发作** 
- C. 失神发作（短暂意识丧失不伴跌倒）
- D. 复杂部分性发作
- E. 肌阵挛发作（快速短暂肌肉收缩）

▼  解析（答案: B）

单纯部分性发作意识保留，Jackson发作为典型代表，抽搐从局部沿皮质运动区顺序扩展。

batch011-M8-B1-002

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P308

意识丧失后出现双侧强直继而阵挛的是：

- **A. 全面性强直阵挛发作** 

- B. 单纯部分性发作
- C. 失神发作（短暂意识丧失不伴跌倒）
- D. 复杂部分性发作
- E. 肌阵挛发作（快速短暂肌肉收缩）

▼  解析（答案: A）

GTCS以意识丧失、双侧强直后出现阵挛为主要特征，是最常见的全面性发作类型。

batch011-M8-B1-003

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P308

| 表现为短暂意识障碍无抽搐脑电图呈3Hz棘慢复合波的是：

- A. 全面性强直阵挛发作
- B. 单纯部分性发作
- C. 失神发作（短暂意识丧失不伴跌倒） 
- D. 复杂部分性发作
- E. 肌阵挛发作（快速短暂肌肉收缩）

▼  解析（答案: C）

典型失神发作表现为短暂意识障碍（数秒至十几秒）、无抽搐、脑电图呈3Hz棘慢复合波，多见于儿童。

batch011-M8-X-001

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P307

| 以下属于全面性发作类型的有：

- A. 强直-阵挛发作（全身性大发作） 
- B. 失神发作（短暂意识丧失不伴跌倒） 
- C. 肌阵挛发作（快速短暂肌肉收缩） 
- D. 失张力发作（肌张力突然丧失致跌倒） 
- E. 复杂部分性发作

▼  解析（答案: A、B、C、D）

癫痫全面性发作包括强直-阵挛、强直、阵挛、失神、失张力和肌阵挛发作。复杂部分性发作为部分性发作类型。

batch011-M8-X-002

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P308

| 全面性强直-阵挛发作（GTCS）的临床表现包括：

- A. 意识丧失 ✓
- B. 强直期后出现阵挛 ✓
- C. 口吐白沫 ✓
- D. 面色发绀 ✓
- E. 发作后意识模糊 ✓

▼  解析（答案: A、B、C、D、E）

GTCS以意识丧失起始，经历强直期→阵挛期→发作后期，可伴口吐白沫、面色发绀、舌咬伤、尿失禁，发作后有意识模糊。

batch011-M8-X-003

| Bloom: 理解 | 难度: 中等 | 教材P311

| 癫痫的辅助检查方法包括：

- A. 脑电图（常规和长程） ✓
- B. 视频脑电图（相关症状） ✓
- C. 头颅MRI（脑实质病变高分辨率成像） ✓
- D. SPECT和PET ✓
- E. 腰椎穿刺脑脊液检查

▼  解析（答案: A、B、C、D）

癫痫辅助检查包括脑电图（常规/长程/视频）、影像学（MRI/CT）、功能影像学（SPECT/PET）等。腰椎穿刺非癫痫常规检查。

batch011-M8-X-004

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P306

| 癫痫发作的常见诱因包括：

- A. 睡眠剥夺 ✓
- B. 情绪激动 ✓
- C. 闪光刺激 ✓
- D. 发热 ✓
- E. 饮酒 ✓

▼  解析（答案: A、B、C、D、E）

癫痫发作的常见诱因包括睡眠剥夺、情绪激动、闪光刺激（反射性癫痫）、发热（热性惊厥）、饮酒及撤酒、过度换气等。

batch011-M8-X-005

| Bloom: 理解 | 难度: 中等 | 教材P315

癫痫持续状态的处理包括：

- A. 保持呼吸道通畅和吸氧 ✓
- B. 静脉注射地西泮 ✓
- C. 纠正水电解质酸碱平衡紊乱 ✓
- D. 防治脑水肿（相关症状） ✓
- E. 寻找和处理病因及诱因 ✓

▼  解析（答案: A、B、C、D、E）

癫痫持续状态处理包括一般措施（保持呼吸道通畅、吸氧、监护）、药物治疗（地西泮等）、并发症防治（脑水肿、酸碱失衡）和病因处理。

batch011-M8-TF-001

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P315

癫痫持续状态是指癫痫发作持续超过30分钟或反复发作且发作间歇期意识未恢复。

- A. 正确 ✓
- B. 错误

▼  解析（答案: A）

符合教材中癫痫持续状态的定义标准，属于神经科急症需紧急处理。

batch011-M8-TF-002

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P69

晕厥发作间期脑电图多正常是与癫痫鉴别的重要依据。

- A. 正确 ✓
- B. 错误

▼  解析（答案: A）

癫痫发作间期脑电图多异常（痫样放电），而晕厥发作间期脑电图多正常，这是两者鉴别的重要依据。

M9 周围神经疾病 (19题)

batch011-M9-A1-001

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P334

三叉神经痛首选的治疗药物是：

- A. 苯妥英钠
- **B. 卡马西平** ✓
- C. 加巴喷丁
- D. 普瑞巴林
- E. 阿米替林

▼  解析（答案: B）

三叉神经痛治疗以止痛为目的，药物治疗为主，卡马西平为首选药物。

batch011-M9-A1-002

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P334

三叉神经痛发作的特点**不包括**：

- A. 发作呈周期性（相关表现）
- B. 缓解期如常人（相关表现）
- C. 神经系统查体一般无阳性体征
- **D. 发作时面部肌肉抽搐** ✓
- E. 疼痛为电击样刀割样

▼  解析（答案: D）

三叉神经痛发作呈周期性，缓解期如常人，查体一般无阳性体征，疼痛为电击样剧痛。面部肌肉抽搐需与面肌痉挛鉴别。

batch011-M9-A1-003

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P336

特发性面神经麻痹（Bell麻痹）的临床表现**不包括**：

- A. 患侧额纹消失
- B. 患侧眼裂变大不能闭合
- C. 患侧鼻唇沟变浅
- **D. 患侧听力丧失** ✓
- E. 口角歪向健侧

▼  解析（答案: D）

特发性面神经麻痹表现为同侧周围性面瘫（额纹消失、不能闭眼、鼻唇沟变浅、口角歪向健侧）。听力丧失不是其典型表现。

batch011-M9-A1-004

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P345-P346

| 吉兰-巴雷综合征（GBS）最常见的首发症状是：

- A. 双下肢感觉减退
- **B. 肢体对称性弛缓性肌无力** ✓
- C. 脑神经麻痹（相关症状）
- D. 自主神经功能障碍
- E. 共济失调（小脑或深感觉通路受损）

▼  解析（答案: B）

GBS首发症状多为肢体对称性弛缓性肌无力（核心症状），自远端向近端发展，多于数日至2周达高峰。

batch011-M9-A1-005

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P346

| 吉兰-巴雷综合征最危险的并发症是：

- A. 下肢深静脉血栓
- **B. 呼吸肌麻痹** ✓
- C. 心律失常
- D. 褥疮感染
- E. 泌尿系感染

▼  解析（答案: B）

严重GBS病例可累及肋间肌和膈肌致呼吸肌麻痹，需密切监测呼吸功能，必要时行气管插管和机械通气。

batch011-M9-A1-006

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P345

| 吉兰-巴雷综合征的发病机制是：

- A. 病毒感染直接损害周围神经
- **B. 自身免疫介导的多发性脊神经根神经病** ✓
- C. 维生素缺乏导致神经变性
- D. 遗传性周围神经病变
- E. 中毒性神经病变

▼  解析（答案: B）

GBS是自身免疫介导的多发性脊神经根神经病，常有前驱感染（如空肠弯曲菌）或疫苗接种诱因。

batch011-M9-A1-007

| Bloom: 记忆 | 难度: 基础 | 教材P345

吉兰-巴雷综合征常见的诱因**不包括**：

- A. 空肠弯曲菌感染
- B. 巨细胞病毒感染
- C. 疫苗接种
- **D. 头部外伤** ✓
- E. 近期手术

▼  解析（答案: D）

GBS常见诱因包括空肠弯曲菌感染（最常见）、巨细胞病毒感染、EB病毒感染、疫苗接种和手术等。头部外伤不是GBS的常见诱因。

batch011-M9-A1-008

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P338

多发性神经病的临床表现特征为：

- A. 不对称性肢体远端感觉运动障碍
- **B. 对称性肢体远端感觉运动障碍** ✓
- C. 仅累及上肢的感觉障碍
- D. 单侧肢体运动障碍
- E. 近端重于远端的肌无力

▼  解析（答案: B）

多发性神经病表现为对称性肢体远端感觉、运动和自主神经功能障碍，呈手套-袜套样分布，远端重于近端。

batch011-M9-A2-001

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P336

患者男，35岁，晨起发现左侧口角漏水左眼**不能**闭合。查体：左侧额纹消失，左眼Bell征阳性，左侧鼻唇沟变浅。最可能的诊断是：

- A. 脑干梗死（椎-基底动脉系统闭塞）
- B. 左侧中枢性面瘫
- **C. 左侧特发性面神经麻痹** ✓

- D. 吉兰-巴雷综合征（GBS，脱髓鞘）
- E. 三叉神经痛（发作性电击样剧痛）

▼  解析（答案: C）

左侧全部表情肌瘫痪（额纹消失+不能闭眼+鼻唇沟变浅），为同侧周围性面瘫，符合特发性面神经麻痹（Bell麻痹）。

batch011-M9-A2-002

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P334

患者女，55岁，反复发作性右侧面部电击样剧痛3个月，可由刷牙洗脸诱发。发作间期完全正常，查体无阳性体征。最可能的诊断是：

- A. 牙痛（牙源性面部疼痛）
- **B. 三叉神经痛（发作性电击样剧痛）** 
- C. 颞下颌关节紊乱
- D. 偏头痛（发作性单侧搏动性头痛）
- E. 舌咽神经痛（相关症状）

▼  解析（答案: B）

反复发作性面部电击样剧痛、有扳机点（刷牙洗脸诱发）、发作间期正常、查体无阳性体征，符合三叉神经痛的典型临床特征。

batch011-M9-A2-003

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P345-P346

患者男，28岁，腹泻后1周出现双下肢对称性无力由远端向近端发展，3天内发展至双上肢。查体：四肢弛缓性瘫痪，腱反射消失。脑脊液蛋白1.2g/L细胞数正常。最可能的诊断是：

- A. 急性脊髓炎（相关症状）
- **B. 吉兰-巴雷综合征（GBS，脱髓鞘）** 
- C. 周期性瘫痪（血钾异常致发作性肌无力）
- D. 多发性肌炎（自身免疫性横纹肌炎症）
- E. 重症肌无力（AChR抗体介导）

▼  解析（答案: B）

前驱感染史+对称性弛缓性瘫痪+腱反射消失+脑脊液蛋白-细胞分离，符合GBS的典型临床表现和实验室特征。

batch011-M9-A2-004

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P346

患者男，35岁，GBS确诊后第3天出现呼吸困难口唇发绀血氧饱和度降至85%。最紧急的处理是：

- A. 增加糖皮质激素剂量
- **B. 行气管插管和机械通气** ✓
- C. 给予大剂量丙种球蛋白
- D. 行血浆置换
- E. 给予呼吸兴奋剂

▼  解析（答案: B）

GBS患者出现呼吸困难和低氧血症提示呼吸肌麻痹，最紧急的处理是气管插管和机械通气以保证呼吸支持。

batch011-M9-A3-001

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P345-P346

患者男，32岁，腹泻后10天出现双下肢对称性无力，2天内由远端向近端发展至双上肢。查体：四肢弛缓性瘫痪，肌力3级，腱反射消失。最可能的诊断是：

- A. 急性脊髓炎（相关症状）
- **B. 吉兰-巴雷综合征（GBS，脱髓鞘）** ✓
- C. 低钾型周期性瘫痪
- D. 重症肌无力（AChR抗体介导）
- E. 多发性肌炎（自身免疫性横纹肌炎症）

▼  解析（答案: B）

前驱感染史+对称性弛缓性瘫痪+腱反射消失+无感觉障碍平面，符合吉兰-巴雷综合征的典型临床表现。

batch011-M9-A3-002

| Bloom: 应用 | 难度: 中等 | 教材P116

该患者脑脊液检查最可能的发现是：

- A. 细胞数和蛋白均显著增高
- **B. 蛋白显著增高而细胞数正常** ✓
- C. 细胞数增高以中性粒细胞为主
- D. 均匀血性脑脊液
- E. 脑脊液各项指标完全正常

▼  解析（答案: B）

GBS典型脑脊液改变为蛋白-细胞分离现象：蛋白质含量明显增高而白细胞计数正常。这是GBS特征性实验室改变。

batch011-M9-A3-003

| Bloom: 分析 | 难度: 中等 | 教材P346

住院第3天患者出现呼吸困难、血氧饱和度降至88%，最紧急的处理是：

- A. 增加糖皮质激素剂量
- **B. 行气管插管和机械通气** ✓
- C. 给予大剂量丙种球蛋白
- D. 行血浆置换治疗
- E. 给予呼吸兴奋剂

▼  解析（答案: B）

GBS出现呼吸困难和低氧血症提示呼吸肌麻痹，最紧急处理是气管插管和机械通气保证呼吸支持。免疫治疗也需进行但非最紧急。

batch011-M9-B1-001

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P334

以面部电击样剧痛为主要表现查体无阳性体征的是：

- **A. 三叉神经痛（相关症状）** ✓
- B. 特发性面神经麻痹
- C. 吉兰-巴雷综合征（GBS，脱髓鞘）
- D. 多发性神经病（对称性远端周围神经受累）
- E. 面肌痉挛（相关临床表现）

▼  解析（答案: A）

三叉神经痛以面部电击样剧痛为特征，查体一般无阳性体征。卡马西平治疗有效。

batch011-M9-B1-002

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P345

以对称性弛缓性瘫痪和蛋白-细胞分离为特征的是：

- A. 三叉神经痛（相关症状）
- B. 特发性面神经麻痹
- **C. 吉兰-巴雷综合征（GBS，脱髓鞘）** ✓
- D. 多发性神经病（对称性远端周围神经受累）
- E. 面肌痉挛（相关临床表现）

▼ 解析（答案: C）

GBS以对称性弛缓性瘫痪和脑脊液蛋白-细胞分离为特征性表现，多有前驱感染史。

batch011-M9-X-001

| Bloom: 理解 | 难度: 中等 | 教材P345-P346

| 吉兰-巴雷综合征的临床特点包括：

- A. 急性或亚急性起病 ☒
- B. 对称性弛缓性瘫痪 ☒
- C. 腱反射减弱或消失 ☒
- D. 脑脊液呈蛋白-细胞分离 ☒
- E. 可有前驱感染史 ☒

▼ 解析（答案: A、B、C、D、E）

GBS临床特点包括急性或亚急性起病、对称性弛缓性瘫痪、腱反射减弱或消失、脑脊液蛋白-细胞分离和常有前驱感染或疫苗接种史。

batch011-M9-X-002

| Bloom: 理解 | 难度: 基础 | 教材P336

| 特发性面神经麻痹的临床表现包括：

- A. 患侧额纹消失 ☒
- B. 患侧眼闭合不全 ☒
- C. 患侧鼻唇沟变浅 ☒
- D. 口角偏向健侧 ☒
- E. 可伴舌前2/3味觉障碍 ☒

▼ 解析（答案: A、B、C、D、E）

特发性面神经麻痹典型表现：同侧额纹消失、不能闭眼（Bell征）、鼻唇沟变浅、口角偏向健侧，病变累及鼓索时可伴味觉障碍。